HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۲ — نسخه بازبینی‌شده

استخوان گونه و قوس گونه‌ای · فک تحتانی · گیجگاهی · آهیانه‌ای و ملاج‌ها

جلسه ۲ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۲) — مهر ۱۴۰۴
متن اصلی: جزوه درس · توضیح تکمیلی با ارجاع جداگانه
تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن و مرور جزوه رونویسی و صفحه‌های منبع و خروجی به‌صورت تصویری بررسی شده‌اند. این نسخه برای کار جزوه‌نویسان آماده شده؛ مقابله مستقل نهایی واژه‌به‌واژه هنوز انجام نشده است. شناسنامه‌ها و شرح شکل‌ها توضیح تکمیلی‌اند.

جای شکل‌ها

قاب‌های مرتبط در همان مبحث یا نزدیک متن آمده‌اند؛ بعضی قاب‌های بزرگ به صفحه بعد منتقل می‌شوند. برش‌ها و شرح‌ها بازبینی تصویری شده‌اند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۲) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۳۵ تصویر از جزوه درس · ۵ از نتر · ۴ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل PDF منبع است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه PDF و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و الزاما برچسب چاپ‌شده خود تصویر نیستند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۲ فصل ۲ — جلسه ۲: استخوان گونه و قوس گونه‌ای · فک تحتانی · گیجگاهی · آهیانه‌ای و ملاج‌ها ۵
۰۱ نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما ۷
۰۲ استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده ۸
۰۳ زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای ۱۰
۰۴ قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند ۱۳
۰۵ سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن ۱۵
۰۶ آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی ۱۷
۰۷ مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز ۱۹
۰۸ سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه ۲۲
۰۹ راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی ۲۴
۱۰ شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع ۲۷
۱۱ سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای ۲۹
۱۲ سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار ۳۲
۱۳ تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم ۳۴
۱۴ سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد ۳۹
۱۵ آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی ۴۲
۱۶ نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی ۴۴
۱۷ برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی ۴۸
۱۸ شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی ۵۲
۱۹ استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی ۵۹
۲۰ سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها ۶۳
۲۱ مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت ۷۲
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۷۷
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۷۸

فصل ۲ · جلسه ۲

از گونه تا آهیانه

جزوه درس · نتر · گری

• ۲۱ مبحث · ۴۴ قاب تصویر (۵ نتر · ۴ گری · ۳۵ جزوه)
• ۰ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
• متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
• نسخه کاری برای جزوه‌نویسان

نقشه جلسه

جلسه ۲ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۳۳ — صفحه‌های منبع و خروجی بازبینی تصویری شده‌اند؛ مقابله مستقل نهایی لفظی باقی است.

تعداد مبحث

۲۱ مبحث

تعداد تصویر

۴۴ قاب تصویر: ۳۵ از جزوه، ۵ از نتر، ۴ از گری.

خروجی این جلسه

استخوان گونه با سه سطح و سه سوراخش، فک تحتانی با شاخ و لندمارک‌هایش، شکستگی‌های شایع صورت، چهار بخش استخوان گیجگاهی با شکاف‌ها و زوائدش، و استخوان آهیانه‌ای با درزها و چهار ملاج را بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۲) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، سر و گردن (پلیت ۳۵، ۳۸، ۳۹ و ۴۲) · گری، فصل ۸ (شکل‌های ۸.۱۸، ۸.۱۹، ۸.۲۱ و ۸.۲۴)

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما	۱–۳	این جلسه چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه و نمای طرفی را می‌آورد
۰۲	استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده	۳	گونه از استخوان‌های زوج صورت است و در کف و جدار خارجی کاسه چشم و دو حفره شریک است
۰۳	زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای	۴	درز پیشانی‌گونه‌ای یک لندمارک پوستی است و دو تکمه، دو اتصال متفاوت دارند
۰۴	قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند	۴	قوس گونه‌ای از دو استخوان ساخته می‌شود و مرز حفره گیجگاهی و زیرگیجگاهی است
۰۵	سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن	۵	سه سوراخ گونه‌ای هر کدام یک شاخه عصب گونه‌ای را عبور می‌دهند
۰۶	آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی	۶	شکستن زائده پیشانی‌گونه‌ای گونه را صاف می‌کند و با دوبینی می‌آید
۰۷	مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز	۷	مندیبل بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت است و از جسم و دو شاخ ساخته می‌شود
۰۸	سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه	۸	چهار کنار جسم و دو صفحه کورتیکال، مسیر شکستگی و بی‌حسی را تعیین می‌کنند
۰۹	راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی	۹	راموس دو زائده کورونوئید و کندیلار دارد و ناچ مندیبولار میان آن‌ها قرار می‌گیرد
۱۰	شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع	۹–۱۰	هفت ناحیه به ترتیب احتمال شکستن، از جسم تا زائده کورونوئید
۱۱	سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای	۱۱–۱۲	سطح داخلی جسم، محل اتصال دو عضله زبان و جای دو غده بزاقی است
۱۲	سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار	۱۱–۱۳	چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل به کار می‌آیند
۱۳	تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم	۱۳–۱۵	تغییرات سنی فک تحتانی و محل سوراخ منتال در تصویرهای جزوه
۱۴	سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد	۱۶	پنج سوراخ نمای قدامی و محتویات هر کدام در یک جدول
۱۵	آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی	۱۷	فاصله هر سوراخ از خط وسط و دامنه تغییرات آن روی پوست
۱۶	نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی	۱۸–۱۹	استخوان گیجگاهی از چهار بخش صدفی، تیمپانیک، استایلوئید و پتروس ساخته می‌شود
۱۷	برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی	۲۰–۲۱	مسیر حرکت کندیل روی برجستگی مفصلی و علت دررفتگی جلو
۱۸	شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی	۲۱–۲۵	شکاف‌های صدفی‌تیمپانیک، تیغه تگمن، بخش تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید
۱۹	استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی	۲۵–۲۷	چهار کنار، چهار زاویه و دو خط گیجگاهی که فاسیا و عضله گیجگاهی را نگه می‌دارند
۲۰	سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها	۲۷–۳۰	ناودان سینوس ساجیتال، جوانه‌های عنکبوتیه، چهار فونتانل و سوراخ آهیانه‌ای
۲۱	مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت	۳۱–۳۳	جمع‌بندی گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه در سه بند و ده کارت مرور

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما

مبحث ۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۱ — دسته‌بندی استخوان‌ها و پنج نمای جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ادامه استخوان‌های جمجمه: چهار استخوانی که در جلسه اول فقط نام‌شان آمد، این‌جا با جزئیات خوانده می‌شوند.

اهداف یادگیری

- چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه را نام ببرید.
- بگویید چرا نمای طرفی برای این چهار استخوان نمای اصلی است.
- برای هر استخوان، یک سطح، یک کنار و یک سوراخ مهم را بگویید.

پیش‌نیاز

جلسه ۱ — دسته‌بندی استخوان‌ها و پنج نمای جمجمه.

جزوه درس، ص ۳

شناسنامه جزوه اصلی

علوم تشریح سر و گردن؛ استاد خدیجه میرزایی؛ پزشکی مهر ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس؛ گروه جزوه نویسی A. جلسه دوم: بررسی استخوان های جمجمه. نام‌های خوانای گروه A در صفحه منبع: نرگس بنایی، پارسا پورشهابی، وحید رحمانیان، عبدالله دردری، طاها سالارحسینی، آریا امیری زاده، محمد نصیری. بخشی از فهرست در تصویر منبع پوشیده شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲ · شناسنامه

این جلسه درمورد ادامه استخوان های جمجمه که شامل: استخوان قدامی (frontalis)، استخوان گونه ای (zygomatic)، استخوان آهیانه ای (parietal)، استخوان گیجگاهی (temporal)، ادامه نماهای جمجمه که شامل نمای طرفی (temporalis) است.

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱: نقشه جلسه — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام استخوان پس‌سری در این جلسه فقط در فهرست آمده و در مبحثی جداگانه خوانده نشده است؛ جای آن جلسه قاعده جمجمه است.

پرسش باز: کدام یک از چهار استخوان این جلسه، در نمای قدامی هم دیده می‌شود و کدام فقط در نمای طرفی؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده

مبحث ۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: تقسیم اسکلت صورت به زوج و فرد

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان گونه مرز بین کاسه چشم، حفره گیجگاهی و حفره زیرگیجگاهی است؛ سه فضایی که در جلسه‌های بعد محتوایشان خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه سطح استخوان گونه را با نام لاتین بگویید.
- پنج کنار را بشمارید و بگویید هر کنار با چه استخوانی مفصل می‌شود.
- دو زائده و نقش هر کدام در قوس گونه‌ای را توضیح دهید.

کلیدواژه

Zygomatic bone · Malar · Orbit · Temporal fossa · Infratemporal fossa

جزوه درس، ص ۳ · نتر، پلیت ۲۷

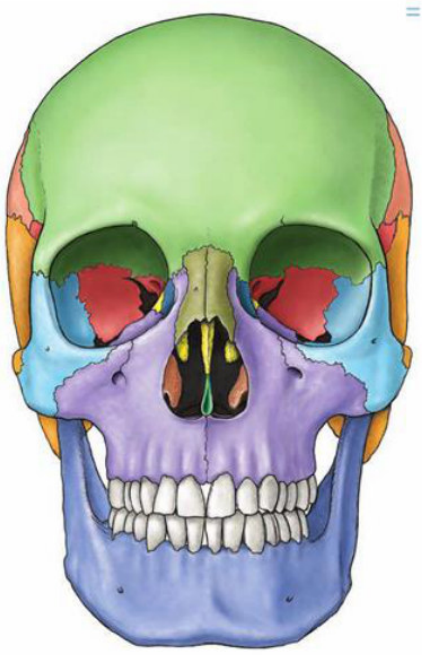
- **Zygomatic bone/Malar**

به استخوان zygomatic استخوان malar هم گفته میشود اما با molar (دندان آسیاب) تفاوت دارد. استخوان زایگوماتیک از استخوان های زوج صورت هست و در تشکیل برجستگی گونه شرکت دارد. این استخوان در تشکیل کف و جدار خارجی کاسه چشم (orbit) و در تشکیل حفرات temporal و infratemporal شرکت می کند. همچنین در تکمیل قوس گونه هم مشارکت دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

استخوان گونه در نمای قدامی، با رنگ

جزوه درس، ص 3 · نمای قدامی جمجمه؛ استخوان گونه رنگی شده است



توضیح تکمیلی تصویر: در نمای قدامی، استخوان گونه در دو طرف و زیر کاسه چشم رنگی نشان داده شده است.

- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان فک فوقانی · Maxilla
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3 · نتر، پلیت ۲۷

این استخوان دارای سه سطح و پنج کنار و دو زائده است. سطوح آن شامل سطح فاسیال یا لترال و سطح کاسه چشمی (orbital) و temporal و همچنین به واسطه زائده گونه ای سطح infratemporal است. کناره ها پنج عدد هستند که شامل قدامی فوقانی (anterosuperior) و قدامی تحتانی (anteroinfrior) و خلفی فوقانی (posterosuperior) و خلفی تحتانی (posteroinferior) و خلفی داخلی (posteromedial) میباشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

این استخوان در کنار قدامی فوقانی در تشکیل حاشیه خارجی و تحتانی کاسه چشم شرکت می کند و همچنین سطح فاسیا را از سطح کاسه چشم جدا میکند. این استخوان در کنار قدامی تحتانی خشن است و با زائده zygomatic با استخوان maxilla مفصل میشود. کنار خلفی داخلی قسمتی از آن در بالا با بال بزرگ استخوان پروانه یا sphenoid مفصل میشود. و در پایین هم با صفحه orbital از استخوان فک فوقانی (maxilla) مفصل میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 3 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۲: استخوان گونه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳ · نتر، پلیت ۲۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، سطح زیرگیجگاهی به‌عنوان سطح چهارم هم شمرده شده اما در فهرست سطوح نیامده؛ این‌جا سطح سوم ذکر شده و سطح زیرگیجگاهی به زائده نسبت داده شده است.

پرسش باز: چرا استخوان گونه با آنکه کوچک است، بیشترین سهم را در شکل صورت دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای

مبحث ۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: سطوح و کنارهای استخوان گونه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

دو زائده استخوان گونه، دو اتصال و دو لندمارک پوستی می‌سازند که در معاینه بالینی لمس می‌شوند.

اهداف یادگیری

- درز پیشانی‌گونه‌ای را روی پوست پیدا کنید.
- تکمه ویتنال و تکمه حاشیه‌ای را از هم جدا کنید.
- رباط‌هایی را که به تکمه ویتنال می‌چسبند نام ببرید.

کلیدواژه

Frontozygomatic suture · Whitnall's tubercle · Marginal tubercle · Lateral palpebral ligament

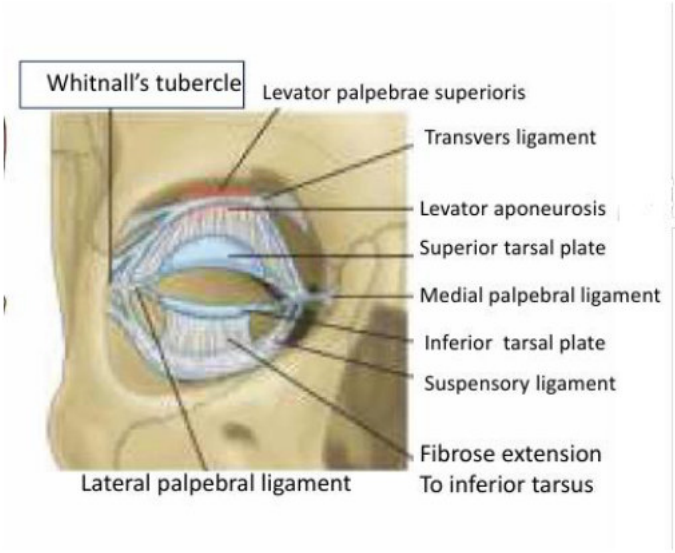
جزوه درس، ص ۴

این استخوان دارای دو زائده است: زائده zygomatic و زائده frontal که با زائده zygomatic از استخوان frontal با هم مفصل میشوند و درز frontozygomatic را تشکیل میدهد. درز frontozygomatic به عنوان یک لندمارک و از روی پوست به صورت تو رفتگی مشخص میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

رباط‌های پلکی و لیگامان معلق روی استخوان گونه

جزوه درس، ص 4 · نمای کاسه چشم؛ محل اتصال رباط پلکی طرفی و آپونوروز بالابرنده پلک



توضیح تکمیلی تصویر: تکمه ویتنال، رباط پلکی طرفی، آپونوروز بالابرنده پلک و لیگامان معلق در تصویر برچسب دارند.

- تکمه ویتنال · Whitnall's tubercle
- رباط پلکی طرفی · Lateral palpebral ligament
- لیگامان معلق · Suspensory ligament
- آپونوروز بالابرنده پلک · Levator aponeurosis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

یک سانتی متر پایین تر از درز frontozygomatic در داخل کاسه چشم تکمه ویتنال (Whitnalls tubercle) وجود دارد که به آن رباط پلکی طرفی (lateral palpebral ligament) و بخشی از آپونوروز عضله بالابرنده پلک فوقانی (Levator palpebrae superioris) و suspensory ligament متصل است.

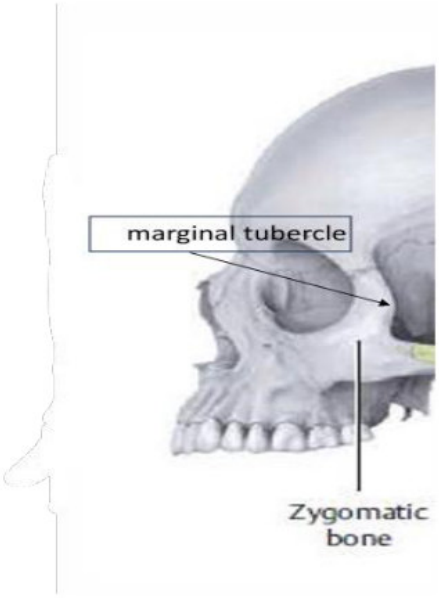
منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

از درز frontozygomatic به سمت پایین marginal tubercle وجود دارد که فاسیا عضله temporalis به این قسمت متصل میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

تکمه حاشیه‌ای روی استخوان گونه

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی؛ محل چسبیدن فاسیای گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: پیکان جای تکمه حاشیه‌ای را بر روی استخوان گونه نشان می‌دهد.

- تکمه حاشیه‌ای · Marginal tubercle
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- فاسیای گیجگاهی · Temporal fascia

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۳: زائده‌ها و درزها — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن درس نام برخی رباط‌های متصل به تکمه ویتنال را ناقص آورده؛ سه موردی که در فهرست آمد، همه موارد ذکرشده در منبع است.

پرسش باز: چرا کنده شدن یک تکمه چند میلی‌متری می‌تواند دوبینی بدهد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند

مبحث ۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: زائده گیجگاهی استخوان گونه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

قوس گونه‌ای پل استخوانی بین صورت و جمجمه است و مرز دو حفره را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو استخوان سازنده قوس را نام ببرید.
- کناره آزاد قوس و اتصال عضلانی آن را بگویید.
- بالا و پایین قوس را به حفره‌های مربوط نسبت دهید.

کلیدواژه

Zygomatic arch · Temporalis fascia · Masseter · Temporal fossa · Infratemporal fossa

جزوه درس، ص ۴

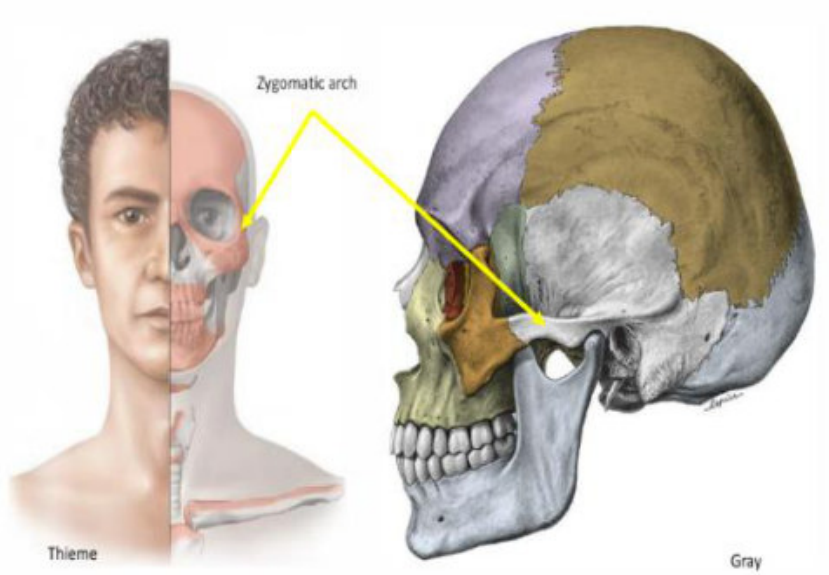
• Zygomatic arch

زائده temporal به سمت عقب رفته و انتهای آن مضرس و محدب هست و با زائده zygomatic از استخوان temporal که انتهای آن هم مضرس و محدب است با هم مفصل میشوند و قوس گونه ای (zygomatic arch) را تشکیل میدهند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

قوس گونه‌ای: مفصل دو استخوان

جزوه درس، ص 4 · سر و جمجمه از نمای طرفی؛ قوس گونه‌ای با رنگ مشخص شده است



توضیح تکمیلی تصویر: مسیر قوس گونه در تصویر سر و در نمای طرفی جمجمه مشخص شده است.

- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

این قوس دارای دو کنار هست: کنار فوقانی و تحتانی. کنار فوقانی آزاد است و به کنار تحتانی عضله جونده متصل میشود. قوس گونه یک شاخص یا لندمارک هست برای تشخیص حفره temporal که در بالای قوس گونه قرار میگیرد و حفره infratemporal که در زیر قوس گونه ای قرار میگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص 4 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۴: قوس گونه‌ای

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، اتصال کنار فوقانی قوس به «کنار تحتانی عضله جونده» آمده؛ همین عبارت در جدول هم تکرار شده و تغییر نکرده است.

پرسش باز: اگر قوس گونه‌ای بشکند، باز کردن دهان چرا محدود می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن

مبحث ۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: شاخه‌های عصب سه‌قلو

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه سوراخ کوچک روی استخوان گونه که هر کدام یک شاخه عصب سه‌قلو را از جمجمه بیرون می‌آورند.

اهداف یادگیری

- سه سوراخ گونه‌ای را با عصب عبوری‌شان جفت کنید.
- مبدأ عصب گونه‌ای را تا عصب سه‌قلو دنبال کنید.
- بگویید هر عصب کدام ناحیه پوست را حس می‌دهد.

کلیدواژه

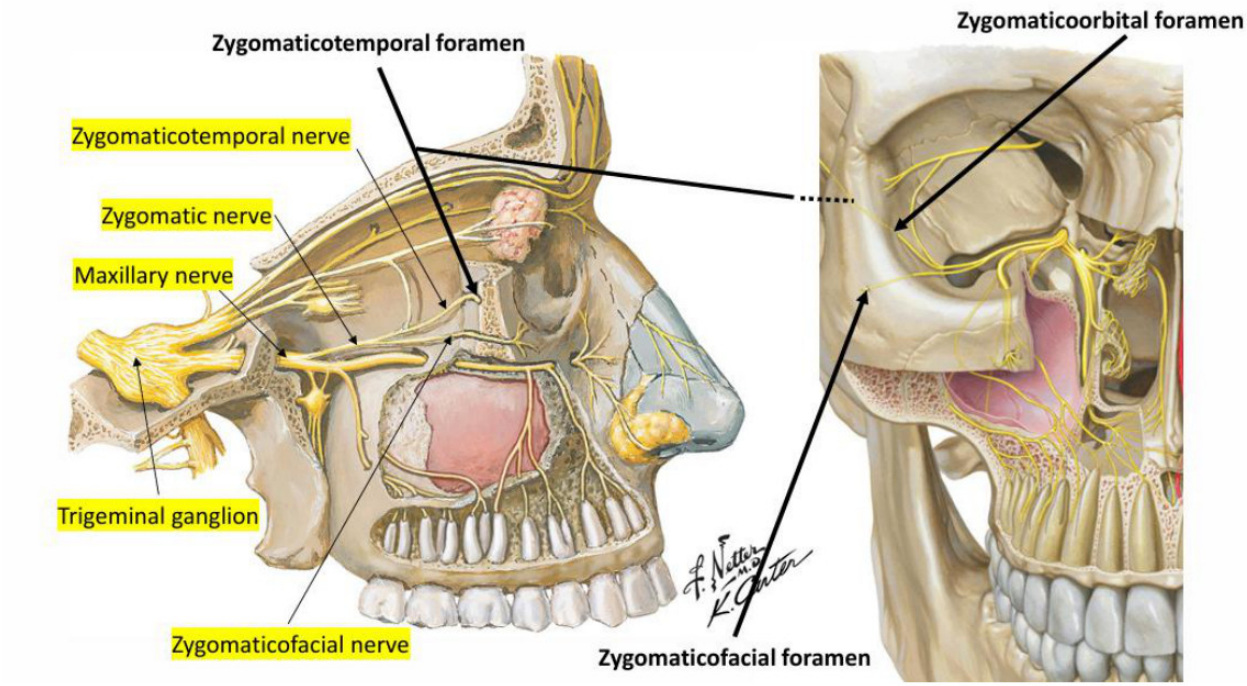
Zygomaticofacial · Zygomaticotemporal · Zygomaticoorbital · Maxillary nerve (V2)

جزوه درس، ص ۵

Foramen

سه سوراخ استخوان گونه و شاخه‌های عصبی

جزوه درس، ص 5 · دو نما؛ سوراخ‌های گونه‌ای‌چهره‌ای، گونه‌ای‌گیجگاهی و گونه‌ای‌کاسه‌ای



توضیح تکمیلی تصویر: دو نمای تصویر، سه سوراخ و شاخه‌های عصب گونه‌ای را با خطوط راهنما نشان می‌دهند.

- سوراخ گونه‌ای‌چهره‌ای · Zygomaticofacial foramen
- سوراخ گونه‌ای‌گیجگاهی · Zygomaticotemporal foramen
- سوراخ گونه‌ای‌کاسه‌ای · Zygomaticoorbital foramen
- عصب گونه‌ای · Zygomatic nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

استخوان دارای سوراخ (foramen) هایی است که بر روی سطوح آن قرار گرفته.

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

Zygomaticofacial foramen سوراخی است که بر روی سطح facial قرار گرفته است و عصب zygomaticofacial nerve از آن عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

سوراخ گونه-کاسه چشمی (zygomatico orbital foramen) که از آن عصب zygomaticotemporal nerve عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

از سوراخ گونه ای-گیجگاهی (zygomaticotemporal foramen) نیز عصب zygomatic و temporal عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

لازم به ذکر است عصب zygomaticotemporal و zygomaticofacial ادامه عصب zygomatic هستند که این عصب از عصب maxillary یا دومین شاخه از عصب پنج مغزی (trigeminal ganglion) مبدأ میگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص 5 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت برای بازبینی علمی

عبارت‌های مربوط به مسیر اعصاب در این قسمت همان بیان منبع‌اند و لازم است جداگانه با مرجع و نظر متخصص بررسی شوند؛ در متن درس دست برده نشده است.

منبع: جزوه درس، ص ۵ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۵: سوراخ‌های گونه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، سوراخ گونه‌ای‌کاسه‌ای در یک جمله با «عصب گونه‌ای‌گیجگاهی» و در جمله بعد با «عصب گونه‌ای و گیجگاهی» آمده؛ هر دو در جدول یک‌جا شده‌اند.

پرسش باز: چرا آسیب به عصب گونه‌ای، حس پوست صورت را کامل از بین نمی‌برد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی

مبحث ۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: تکمه ویتنال و رباط معلق کره چشم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بالینی‌ترین مبحث استخوان گونه: چه می‌شکند، چه علامتی می‌دهد و چرا دوبینی می‌آید.

اهداف یادگیری

- مسیر عصب و شریان سوپرااوربیتال را توضیح دهید.
- سه علامت شکستگی زائده پیشانی‌گونه‌ای را بشمارید.
- علت دوبینی را از مسیر رباط‌ها توضیح دهید.

کلیدواژه

Black eye · Periorbital hematoma · Depressed cheek · Diplopia

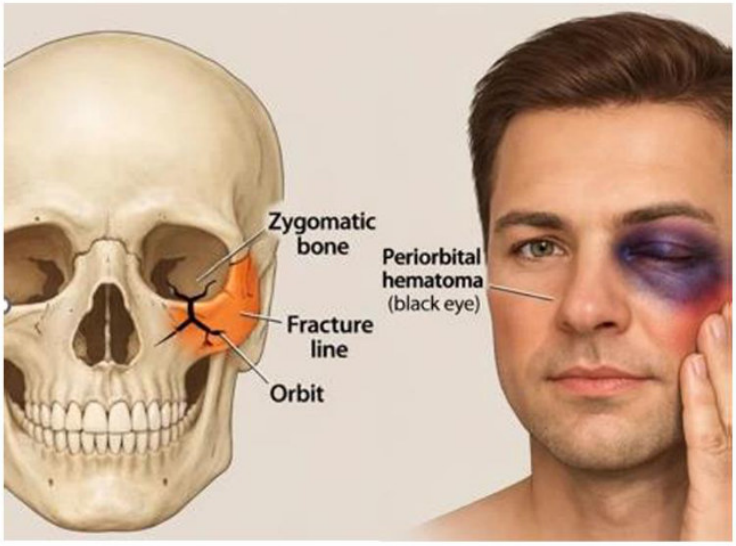
جزوه درس، ص ۶

در جایی که superciliary arch وجود دارد اگر یک وسیله تیز در این قسمت باعث پارگی شریان superaorbital شود اگر همراه با پارگی پوست باشد خون بیرون آمده و اگر پوست پاره نشود خون زیر پوست جمع شده و به سمت پایین آمده و به سمت دور چشم خون مردگی ایجاد می کند که به آن سایه دور چشم (black eye) میگویند.

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

شکستگی گونه و کبودی دور چشم

جزوه درس، ص 6 · نمای قدامی جمجمه در کنار عکس بیمار با کبودی دور چشم



توضیح تکمیلی تصویر: در سمت جمجمه خط شکستگی و در سمت صورت کبودی دور چشم نشان داده شده است.

- کبودی دور چشم · Periorbital hematoma
- خط شکستگی · Fracture line
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- کاسه چشم · Orbit

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

همچنین در گونه بیمار روی برجستگی گونه قرمز و گرم میشود که به آن سرخی ناحیه گونه گفته میشود. مشت به گونه باعث میشود زائده forental بشکنه و گاهی اوقات ممکن است از زائده zygomatic جدا بشود و به سمت پایین و داخل استخوان کشیده شود و برجستگی گونه برطرف شود و چندین علامت دارد در صاف شدن گونه و تورم و همچنین دوبینی ممکن است ایجاد شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

دلیل دوبینی این است که ربات پلکی خارجی به تکمه ویتنال متصل میشود و همچنین suspensory ligament به طرف پایین کشیده میشود بنابراین کره چشم را به سمت پایین و خارج می آورد و باعث دوبینی میشود. همچنین از علامت دیگر آن مورمور شدن یا بی حسی است و همچنین علامت دیگر گونه فرو رفته یا depressed check که اگر عناصر روی چشم نیز متورم بشوند کره چشم بیرون میزند.

منبع: متن جزوه درس، ص 6 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۶: آسیب گونه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا دوبینی در شکستگی گونه معمولا چند روز بعد بیشتر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز

مبحث ۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: تفاوت استخوان زوج و فرد در صورت

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت؛ تنها استخوان متحرک جمجمه و میزبان دندان‌های پایین.

اهداف یادگیری

- دو بخش مندیبل را نام ببرید و شکل جسم را توصیف کنید.
- سمفیز و برجستگی چانه را از هم تشخیص دهید.
- محل حفره دو بطنی و اتصال عضله آن را بگویید.

کلیدواژه

Mandible · Body · Ramus · Symphysis · Mental protuberance · Digastric fossa

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۹

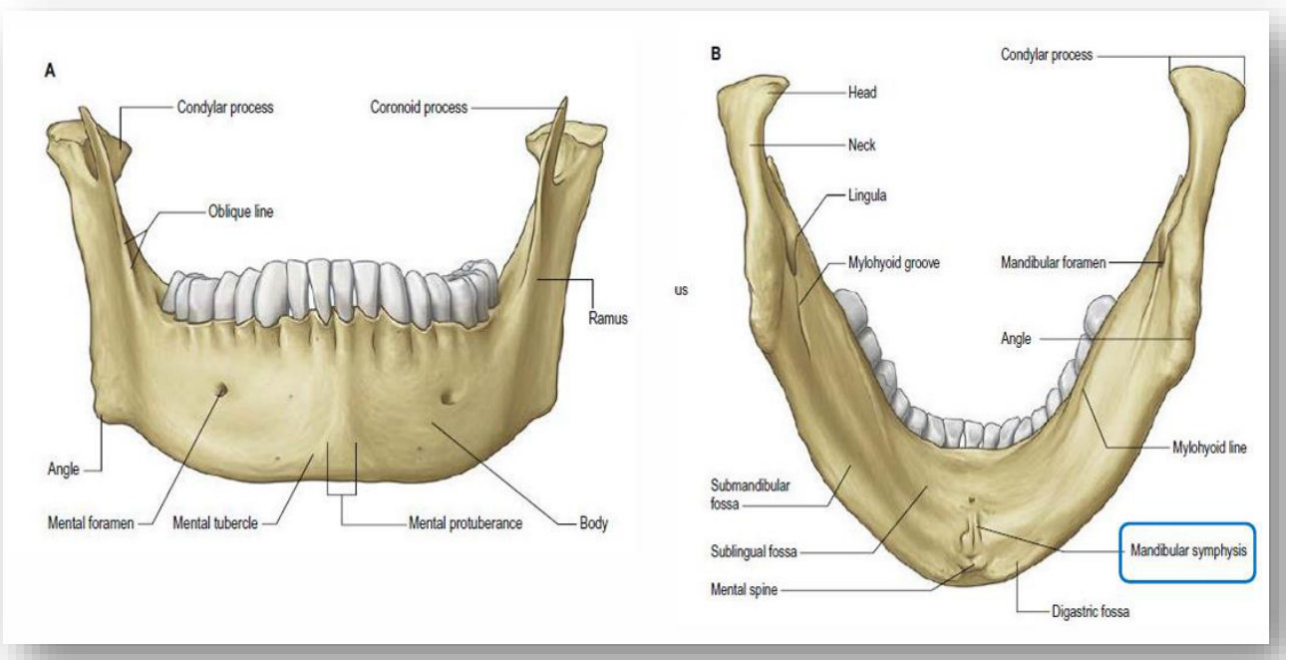
Mandible bone

استخوان mandible بزرگترین و پایین ترین و قویترین استخوان صورت هست و از body یا جسم و دو ramus یا شاخ تشکیل تشکیل شده. body به صورت U شکل هست که تحدب آن رو به جلوست و تقعر آن به سمت عقب میباشد و به صورت افقی (horizontal) قرار گرفته است. استخوان دارای دو سطح درونی و بیرونی (external-internal) هست و دارای دو کنار فوقانی و تحتانی هست.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

استخوان مندیبل از دو نما

جزوه درس، ص 7 · نمای بیرونی و نمای درونی مندیبل با برچسب



توضیح تکمیلی تصویر: این تصویر دو نمای مکمل است: در نمای بیرونی، خط مایل و سوراخ چانه دیده می‌شود؛ در نمای درونی، خط مایلوهایوئید و سوراخ فک تحتانی. هر مبحث بعدی این جلسه روی یکی از همین دو نما می‌نشیند.

- زائده کندیلار · Condylar process
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- ناچ مندیبولار · Mandibular notch
- جسم · Body
- شاخ (راموس) · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7 · نتر، پلیت ۳۹

در کنار فوقانی ریشه دندان های فک تحتانی قرار گرفته و در کنار تحتانی که محدوده آن تا موازات سومین دندان آسیای بزرگ است. در این قسمت حفره ای به نام حفره دو بطنی (digastric fossa) قرار گرفته که بطن قدامی عضله digastric در این قسمت قرار میگیرد.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

در خط وسط یک برجستگی وجود دارد که از بالا شروع شده و به پایین میاد و در بچه ها به آن mandibular symphysis گفته میشود. symphysis محل رسیدن دو چیز میباشد. در قسمت symphysis به جز غضروف بافت لیفی هم در آن قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 — رونویسی در حال مقابله

خط سمفیز (symphysis) زمانی که به سمت پایین بیاد به دو طرف زاست و چپ میرود و در وسط آن گودی ایجاد میشود که مثلثی شکل است که قائده ی ان در سمت پایین قرار گرفته است در دو طرف برجسته است mental tubercle یا تگمه ی منتال یا چانه را تشکیل میدهد و مثلث، تو رفتگی ها و توبرکل ها مجموعا باهم برحستگی چانه ای (mental protubrance) را ایجاد میکنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۷: مندیبل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا مندیبل تنها استخوان متحرک جمجمه است و حرکت آن به چه چیزی وابسته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه

مبحث ۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: ساختار جسم مندیبل

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار کنار جسم و دو صفحه استخوانی آن، هم مسیر شکستگی را می‌سازند و هم مسیر بی‌حسی دندان‌ها را.

اهداف یادگیری

- خط مایل را از تکمه چانه تا کنار قدامی راموس دنبال کنید.
- دو صفحه کورتیکال و دو دیواره بین‌دندانی را نام ببرید.
- زاویه مندیبل را تعریف کنید و تفاوت جنسی آن را بگویید.

کلیدواژه

Oblique line · Alveolar bone · Angle of mandible · Buccal/Lingual plate · Interdental septum

جزوه درس، ص ۸

نیم راه بین کنار فوقانی و کنار تحتانی سوراخ منتال بین پره مولار ۱ و ۲ یا زیر پره مولار ۲ قرار میگیرد لازم به ذکر است که دندان ها شامل: پیش مرکزی / پیش میانی / نیش یا (canine) / آسیاب کوچک یا پره مولار / آسیاب بزرگ یا مولار است. از فورامن منتال عصب منتال که شاخه ی عصب اینفریور آلوئولار است عبور میکند.

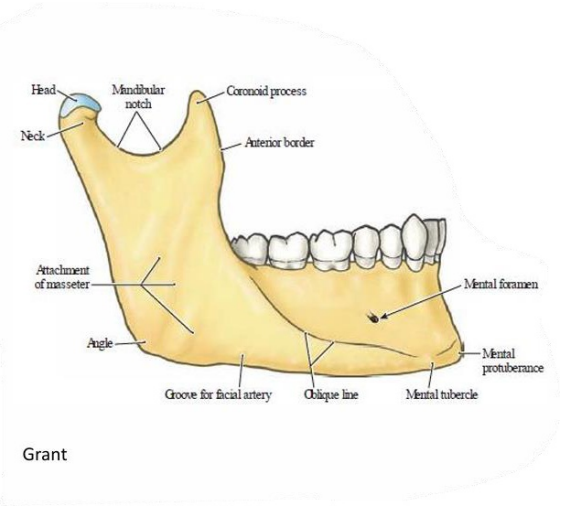
منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

در این تصویر نمای بیرونی مندیبل را مشاهده میکنید که این بخش بادی است و از قسمت عقب بادی، راموس یا شاخ به سمت عقب و بالا و خارج کشیده شده و دارای ۴ کنار هست: کنار فوقانی / کنار قدامی / کنار تحتانی / کنار خلفی.

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

سطح بیرونی جسم و راموس مندیبل

جزوه درس، ص 8 · نمای طرفی مندیبل؛ خط مایل، زاویه و سوراخ چانه



توضیح تکمیلی تصویر: خط مایل، سوراخ چانه‌ای، زاویه و زائده‌های راموس با برچسب مشخص شده‌اند.

- خط مایل · Oblique line
- زاویه مندیبل · Angle of mandible
- سوراخ چانه · Mental foramen
- تکمه چانه · Mental tubercle
- زائده کورونوئید · Coronoid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

کنار تحتانی قاعده یا بادی استخوان مندیبل تا موازات سومین دندون مولار است و در ادامه با کنار تحتانی شاخ یا راموس ممتد میشود. از منتال توبرکل (Mental Tubercle) خط مایل (Oblique Line) به سمت بالا، عقب، خارج رفته و به موازات سومین دندان آسیا کشیده میشود و با کنار قدامی شاخ یا راموس ممتد میشود. خط مایل بیرونی هرچقدر به سمت عقب برود برجسته تر میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

کنار فوقانی استخوان را زائده الوئولار (Alveolar Bone) یا حفره دار یا الوئولوس فوسا میگویند که در هر نیمه 8 عدد دندان در این قسمت وجود دارد. کنار تحتانی راموس + کنار خلفی Angel یا زاویه مندیبل را تشکیل میدهد که در مردان به سمت بیرون و در زنان به سمت داخل تمایل دارد.

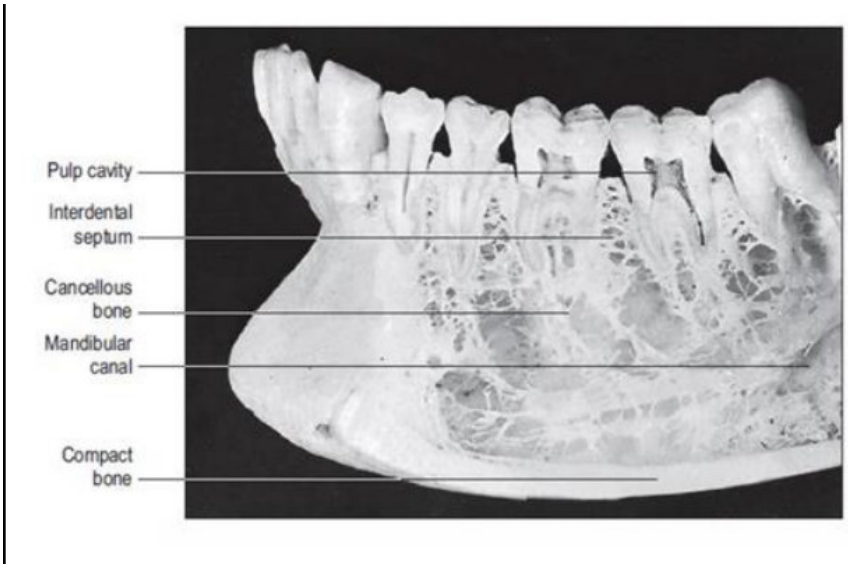
منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

جسم دارای 2 صفحه یا کورتیکال پلیت است: باکال Buccal لایه استخوانی سمت گونه ای؛ لینگوئال Lingual لایه استخوانی سمت زبانی. در بین این دو (Septum Interdental) یا دیواره بین دندانی قرارگرفته همچنین در داخل هریک از این حفرات نیز (interradicular septum) قرار گرفته و این حفره را به ۲ الی 3 حفره برای ریشه دندان های اسیا تقسیم میکند. به قاعده مندیبل (Base) هم گفته میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 8 — رونویسی در حال مقابله

مندیبل در رادیوگرافی

جزوه درس، ص 8 · رادیوگرافی مندیبل؛ حفره‌های دندانی، سپتوم‌ها و کانال مندیبولار



توضیح تکمیلی تصویر: حفره پالپ، سپتوم بین‌دندانی، استخوان اسفنجی، کانال مندیبل و استخوان متراکم در تصویر برچسب دارند.

- حفره پالپ · Pulp cavity
- سپتوم بین‌دندانی · Interdental septum
- کانال مندیبولار · Mandibular canal
- استخوان متراکم · Compact bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۸: سطح بیرونی جسم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا شکستگی جسم مندیبل اغلب هم‌زمان ریشه دندان نیش را درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی

مبحث ۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: کنارهای جسم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

راموس دو زائده دارد؛ یکی عضله می‌کشد و دیگری مفصل می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو زائده کنار فوقانی راموس را با عضله یا مفصلشان بشناسید.
- ناچ مندیبولار را تعریف کنید و محتوای آن را بگویید.
- دو سطح راموس را نام ببرید.

کلیدواژه

Coronoid process · Condylar process · Mandibular notch · Temporalis · Masseter · TMJ

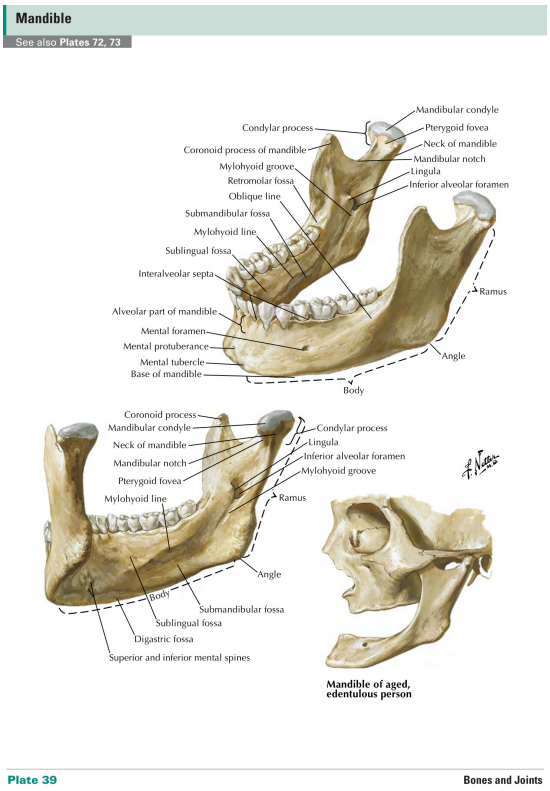
جزوه درس، ص ۹ · نتر، پلیت ۳۹ و ۴۲

راموس دارای دو سطح است: Lateral و Medial. در کنار فوقانی دو زائده وجود دارد: Coronoid و Condylar.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 — رونویسی در حال مقابله

مندیبل در نتر: نمای طرفی، مدیال و مقایسه سنی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۹، ص ۹۱ · پلیت ۳۹ نتر



Mandible

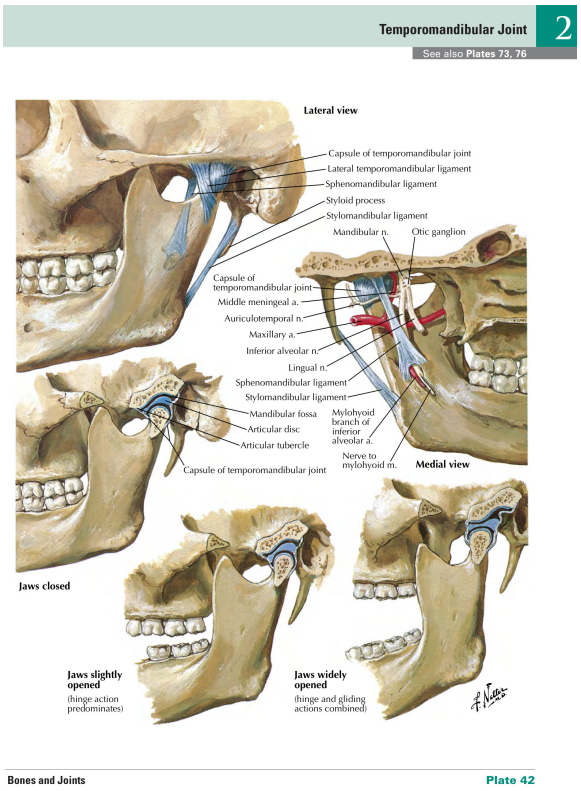
توضیح تکمیلی تصویر: پلیت نتر همان دو نمای این مبحث را بزرگ‌تر نشان می‌دهد و در کنارش مندیبل سالمند آمده است؛ همان چیزی که در مبحث تغییرات سنی به آن می‌رسیم.

- زائده کندیلار · Condylar process
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- ناچ مندیبولار · Mandibular notch
- سوراخ چانه · Mental foramen
- مندیبل سالمند · Mandible of aged

ارجاع متن: نتر، پلیت 39

مفصل گیجگاهی‌مندیبلی در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۲، ص ۹۴ · پلیت ۴۲ نتر



Temporomandibular Joint

توضیح تکمیلی تصویر: در این پلیت سه چیز را ببینید: کپسول مفصل، دیسک بین دو استخوان و رباط‌های کنار آن. هر حرکتی که در مبحث برجستگی مفصلی می‌خوانید، داخل همین کپسول رخ می‌دهد.

- دیسک مفصلی · Articular disc
- کپسول · Capsule
- رباط طرفی · Lateral ligament
- رباط اسفنومندیبولار · Sphenomandibular ligament
- رباط استایلومندیبولار · Stylomandibular ligament

ارجاع متن: نتر، پلیت 42

زائده Condylar با حفره کندیلار از استخوان temporal مفصل می شود و مفصل Temporal Mandible Goint = Tmg را تشکیل میدهد و زائده ی کرونوئید در قسمت جلو یا زائده ی منقاری که تاندون عضله ی تمپورالیسم از عضلات جونده به این قسمت متصل میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 – رونویسی در حال مقابله

بین زائده ی کندیلار و زائده کورونوئید یک نتچ یا بریدگی است که به آن مندیبولار ناچ (Mandibular Notch) گفته میشود که عروق و اعصاب برای عضله مسیتر (Masseter) (یکی از مهم ترین عضلات ناحیه صورت و فک که نقش بسیار مهمی در عمل جویدن دارد) از این قسمت عبور میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۹: راموس و TMJ

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹ · نتر، پلیت ۳۹ و ۴۲

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا عضله گیجگاهی به زائده کورونوئید می‌چسبد و نه به کندیل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع

مبحث ۱۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: آناتومی جسم، زاویه و زوائد

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

هفت ناحیه شکستن مندیبل به ترتیب شیوع؛ کاربردی‌ترین جدول این جلسه برای بخش بالینی.

اهداف یادگیری

- ترتیب شیوع شکستگی‌ها را از اول تا هفتم بگویید.
- بگویید چرا شکستگی جسم با ریشه نیش هم‌سطح است.
- کدام شکستگی با دررفتگی مفصل همراه است؟

کلیدواژه

Body fracture · Angle · Condylar neck · Symphysis · Ramus · Alveolus · Coronoid

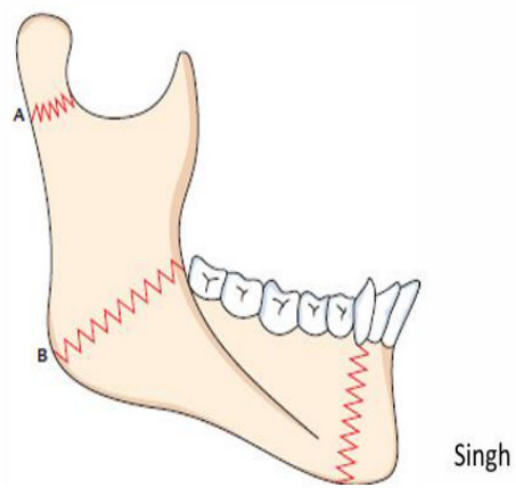
جزوه درس، ص ۹–۱۰

در اثر ضربه به استخوان مندیبل یکسری شکستگی ها در آن ایجاد میشود که به ترتیب شیوع شکستگی در جسم بیشتر شایع است یعنی این که جسم بیشتر دچار شکستگی میشود و ریشه ی دندان نیش را درگیر میکند که در ارتفاع جسم فک تحتانی در موازات ریشه ی دندان نیش است و منتال فورامن به صورت عرضی در این قسمت شکستگی ایجاد میشود اگر شکستگی در قسمت انگل (Angel) مندیبل معمولا مایل است و میتواند حفره ی آلوئولار Alveolar دندان آسایب سوم هم درگیر کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 – رونویسی در حال مقابله

زاویه مندیبل و خطوط شکستگی

جزوه درس، ص 9 · طرح‌واره مندیبل؛ خطوط شکستگی در ناحیه زاویه و آلوئول



توضیح تکمیلی تصویر: خطوط دندانه‌دار طرح‌واره مسیرهایی را در گردن کندیل، زاویه و جسم مندیبل نشان می‌دهند.

- زاویه مندیبل · Angle of mandible
- زائده آلوئولار · Alveolar part
- راموس · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

ناحیه بعدی که در معرض شکستگی است زائده ی کندیلار است که معمولا در ناحیه ی گردن شکستگی ایجاد میشود و معمولا با در رفتن مفصل TMG همراه میباشد شکستگی زائده ی کرونوئید به ندرت اتفاق می افتد و شایع نمی باشد البته شکستگی ها در سمفیز منتال و همچینین راموس هم اتفاق می افتد.

منبع: متن جزوه درس، ص 9 – رونویسی در حال مقابله

بنابرین شکستگی ها به ترتیب:

منبع: متن جزوه درس، ص 10 – رونویسی در حال مقابله

۱ جسم استخوان که در موازات دندان نیش بر روی جسم

۲ در انگل مندیبل

۳ زائده ی کندیلار

۴ سمفیز منتال

۵ راموس

۶ Alveolus جایی که ریشه سوم دندان آسیا قرار میگیره

۷ نادر ترین هم در زائده ی کرونوئید استخوان میباشد

منبع: متن جزوه درس، ص 10 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۰: شکستگی‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: اگر شکستگی زاویه با دندان عقل درگیر باشد، برنامه درمان چه تفاوتی می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای

مبحث ۱۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: سطح بیرونی جسم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سطح داخلی جسم، دو عضله زبان و دو غده بزاقی را از هم جدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- چهار خار چانه‌ای را نام ببرید و عضله هر کدام را بگویید.
- خط مایلوهایوئید را از مبدأ تا انتها دنبال کنید.
- حفره زیرزبانی و زیرمندیبولی را از هم جدا کنید.

کلیدواژه

Genial tubercles · Mylohyoid line · Sublingual fossa · Submandibular fossa · Genioglossus · Geniohyoid

جزوه درس، ص ۱۱

در این تصویر عناصری که در سطح مدیال یا داخلی راموس و همچنین در سطح اینترنال یا درونی بادی مندیبل است را مشاهده میکنید. در سطح درونی جسم استخوان ۲ تا اسپاین (spine) یا خار مشاهده میشود:

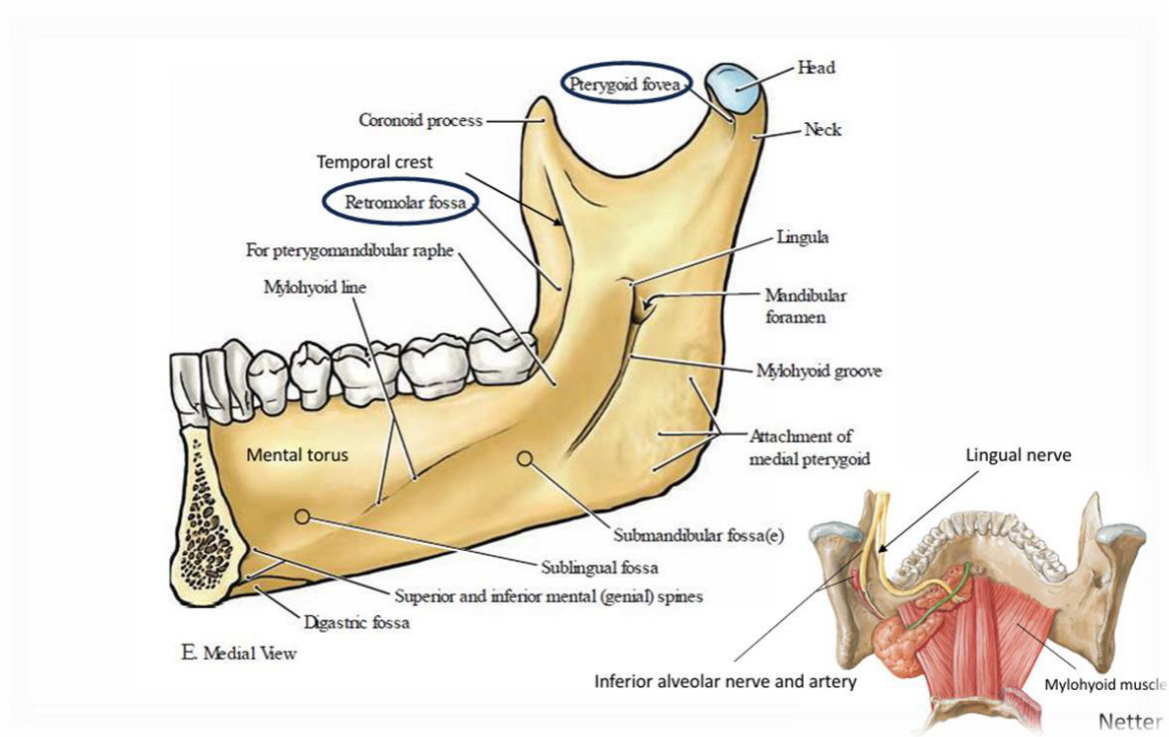
منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

- سوپریور منتال اسپاین یا خارهای چانه ای فوقانی
- اینفریور منتال اسپاین یا خارهای چانه ای تحتانی

منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

سطح داخلی جسم و راموس مندیبل

جزوه درس، ص 11 · نمای درونی مندیبل با برچسب کامل



توضیح تکمیلی تصویر: نمای داخلی مندیبل دارای برچسب خارهای چانه‌ای، خط مایلوهایوئید، حفره‌ها، سوراخ مندیبل و لینگولا است.

- تکمه‌های چانه‌ای · Genial tubercles
- خط مایلوهایوئید · Mylohyoid line
- حفره زیرزبانی · Sublingual fossa
- حفره زیرمندیبولی · Submandibular fossa
- سوراخ فک تحتانی · Mandibular foramen
- لینگولا · Lingula
- شیار مایلوهایوئید · Mylohyoid groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

گاهی این خار باهم متصل میشوند و یک خار را تشکیل میدهند در بالای محل این خارها محل اتصال عضله ی جنیو گلوز (genioglossue muscle) و در پایین محل عضله جنیو هایوئید (geniohyoid muscle) است که در درس های آینده تدریس خواهد شد.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

گاهی اوقات این دو برجستگی نیستند و جای آن ها یک بخش زبر و نامنظم قرار گرفته است به این خار ها جنیال توبرکل هم گفته میشود همچنین در این سطح خط مایلوهایوئید (mylohyoid line) را مشاهده میکنید مایلو به معنی دندان آسیاب است و هایوئید نیز به معنای استخوان لامی شکل است.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 — رونویسی در حال مقابله

این خط در قسمت جلو زیاد مشخص نیست اما در قسمت عقب برجسته تر است این خط از یک سانتی متری پایین سومین دندان آسیاب بزرگ شروع میشود سپس به سمت جلو و پایین اومده و تا موازات سمفیز منتال ادامه پیدا میکند در بالای این خط ساب لینگوئال فوسا (sublingual fossa) قرار گرفته که غده ی بزاقی ساب لینگوئال در این قسمت قرار میگیرد و در پایین این خط حفره ی ساب مندیبولار (submandibular fossa) است و غده ی بزاقی ساب مندیبولار در این قسمت واقع میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11 – رونویسی در حال مقابله

برجستگی زیر دندان های پرمولار را منتال تورس (mental torus) میگویند که این برجستگی برای گذاشتن دندان های مصنوعی مزاحمت ایجاد میکند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

زیر قسمت خلفی خط مایلو هایوئید شیار مایلو هایوئید قرار گرفته اینجا جایی است که عصب لینگوئال عبور میکند و عصب ریشه ی دندان آسیاب سوم نزدیک میشود در همینجا هم ریشه ی دندان عقل است در کشیدن دندان عقل باید به این مورد دقت شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت برای بازبینی علمی

بیان مسیر عصب در این بند از متن درس حفظ شده و نیاز به بررسی مستقل با منابع آناتومی دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲ · توضیح تکمیلی · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۱: سطح داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا خط مایلوهایوئید در جلو مشخص نیست و در عقب برجسته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار

مبحث ۱۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۳ · پیش‌نیاز: سطح داخلی راموس

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل مستقیما به کار می‌آیند.

اهداف یادگیری

- مسیر عصب و شریان فک تحتانی را از سوراخ تا سوراخ چانه بگویید.
- لینگولا را تعریف کنید و اتصال آن را بشناسید.
- مثلث رتروملار را با سه ضلعش توصیف کنید.

کلیدواژه

Mandibular foramen · Lingula · Mylohyoid groove · Temporal crest · Retromolar fossa · Pterygoid fovea

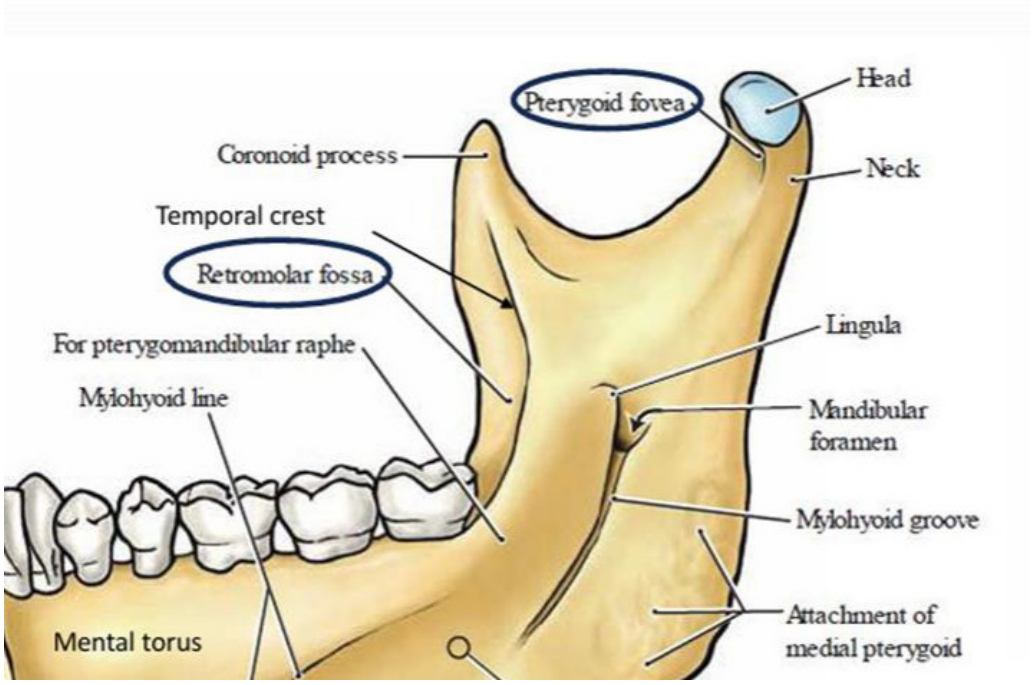
جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · نتر، پلیت ۳۹

در سطح داخلی راموس نیمه راه کنار قدامی و کنار خلفی راموس مندیبولار فورامنت یا سوراخ فک تحتانی قرار گرفته است که از این سوراخ شریان و عصب inferior alveolar یا فک تحتانی عبور میکند و در ادامه ی این سوراخ کانال وجود دارد که عصب در این کانال مسیر خود را طی می کند و از سطح اکسترنال بادی از سوراخ منتال mental خارج می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 — رونویسی در حال مقابله

لینگولا، سوراخ مندیبل و مثلث رتروملار

جزوه درس، ص ۱۱ · برش جزئی از تصویر سطح داخلی راموس در جزوه



توضیح تکمیلی تصویر: در همین تصویر سوراخ مندیبل، لینگولا، شیار مایلوهایوئید و رتروملار فوسا دیده می‌شوند.

- لینگولا · Lingula
- سوراخ مندیبل · Mandibular foramen
- حفره رتروملار · Retromolar fossa

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

در بالا جلو و داخل مندی بولار فرامن (Mandibular foramen) (سوراخ فک تحتانی) لینگولا (Lingula) قرار گرفته که یک تیغه ی استخوانی زبانی شکل هست که رافع ی پتریگو مندی بولار (Pterygomandibular raphe) به این قسمت متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

در زیر لینگولا (Lingula) شیار مایلوهایوئید (Mylohyoid groove) (مایلوهایوئید گروو) شروع می شود به طرف پایین و جلو طی مسیر کرده و نرسیده به جسم محو می شود در این شیار عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid groove) قرار می گیرد عصب مایلوهایوئید که در این شیار قرار می گیرد به عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid muscle) عصب رسانی می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

یک برجستگی استخوانی از زیر رأس زائده ی کرونوئید (Coronoid process) شروع می شود و به سمت پایین می آید و تا خلف سومین مولار کشیده می شود که به آن تمپرال کرست (Temporal crest) گفته می شود بین تمپورال کرست و کنار قدامی شاخ مندیبل (راموس) و همچنین در قسمت خلف سومین دندان آسیای بزرگ (مولار سوم) یک حفره ای به اسم حفره رترومولار فوسا (Retromolar fossa) یا تریگون یا مثلث رترومولار تشکیل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

رترو به معنی خلف و مولار به معنی دندان آسیاب می باشد رترو مولار فوسا یا تریگون یک ناحیه لنت مارک مهم در قسمت پشت مولار سوم هست که در بلوک های عصبی همچنین در طراحی پروتز های دندانی حائز اهمیت بالینی می باشد بین تمپورال کرست و همچنین کنار قدامی راموس مندیبل، رترو مولار فوسا یا تریگون قرار گرفته از لای این مثلث تمپورال کرست کنار قدام شاخ مندیبل و قسمت خلفی سومین دندان آسیای بزرگ یا سومین مولار می باشد اهمیت بالینی رترو مندی بولار فوسا یا تریگون برای بلوک های عصبی و همچنین طراحی پروتزهای دندانی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

در قسمت قدام گردن زائده کوندیلار این استخوان یک حفره کوچک به اسم پتریگوییید فووآ (Pterygoid fovea) وجود دارد که محل چسبیدن عضله پتریگوئید خارجی از عضلات جونده می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 12 – رونویسی در حال مقابله

در قسمت قدام گردن زائده کوندیلار استخوان مندیبل یک حفره کوچک به نام پتریگوییید فووآ قرار گرفته که عضله پتریگوییید خارجی از عضلات جونده در این قسمت متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 13 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۲: لندمارک‌های داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا در کشیدن دندان عقل، دانستن جای لینگولا از دانستن جای دندان مهم‌تر است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم

مبحث ۱۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: ساختار جسم و راموس

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مندیبل از دو مرکز استخوان‌سازی شروع می‌شود و رشدش به سمت عقب است، نه جلو؛ همین دو نکته کل مبحث است.

اهداف یادگیری

- دو مرکز استخوان‌سازی و زمان‌شان را بگویید.
- جهت رشد راموس و زوائد را توضیح دهید.
- تغییر جای سوراخ چانه و کانال مندیبولار با سن را بیان کنید.

کلیدواژه

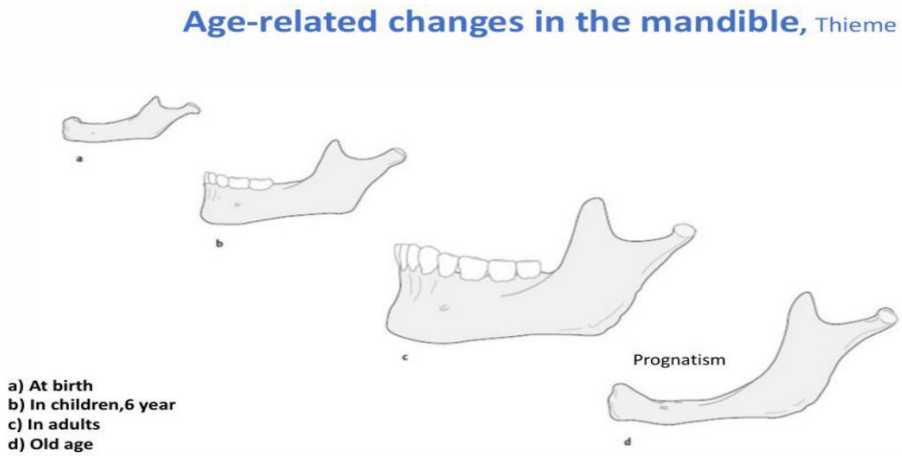
Ossification center · Symphysis · Prognathism · Edentulous mandible · Mandibular canal

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · نتر، پلیت ۳۹

- **تغییرات سنی در مندیبل Mandible چطوری است؟**

مندیبل در چهار مرحله سنی

جزوه درس، ص 13 · تغییرات سنی مندیبل: هنگام تولد، شش‌سالگی، بزرگسالی و سالمندی



توضیح تکمیلی تصویر: چهار طرح‌واره تصویر به‌ترتیب تولد، کودک شش‌ساله، بزرگسال و سالمند را نشان می‌دهند.

- در زمان تولد · At birth
- در شش‌سالگی · At 6 years
- در بزرگسالی · In adults
- در سالمندی · Old age

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

دو تا مرکز استخوان سازی در دوران جنینی در مندیبل تشکیل میشه یکی هفته ی ششم در جایی که باید سوراخ منتال (Mental) یا چانه تشکیل بشود و دیگری در هفته دهم در جایی که باید دندان های پیشین اولیه تشکیل بشود این مراکز استخوان سازی در قالب غضروف مندیبل شروع به استخوان سازی می کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 13 — رونویسی در حال مقابله

در نیمه دوران جنینی غضروف مندیبل بیشتر با استخوان جایگزین میشه اما قسمت پروگزیمال اون که سنفیز منتیل است تا سن سی سالگی غضروف باقی می ماند خب سپس دو تا استخوان مندیبل در دوران جنینی به سمت هم رشد پیدا می کنن و به هم متصل می شوند و یک استخوان واحد مندیبل رو به وجود می آورند پس استخوان مندیبل دو تا تیکه هست و با اتصال اونها به شکل فک تحتانی که U شکل هست در می آید.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ — رونویسی در حال مقابله

تعارض قابل بررسی در خود جزوه

صفحه ۱۳ «سی سالگی» را ذکر می‌کند، در حالی که صفحه ۱۴ از جوش خوردن دو نیمه در سال‌های اول تا سوم پس از تولد سخن می‌گوید. هر دو عبارت جداگانه حفظ شده‌اند و نیازمند بررسی علمی‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · توضیح تکمیلی · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

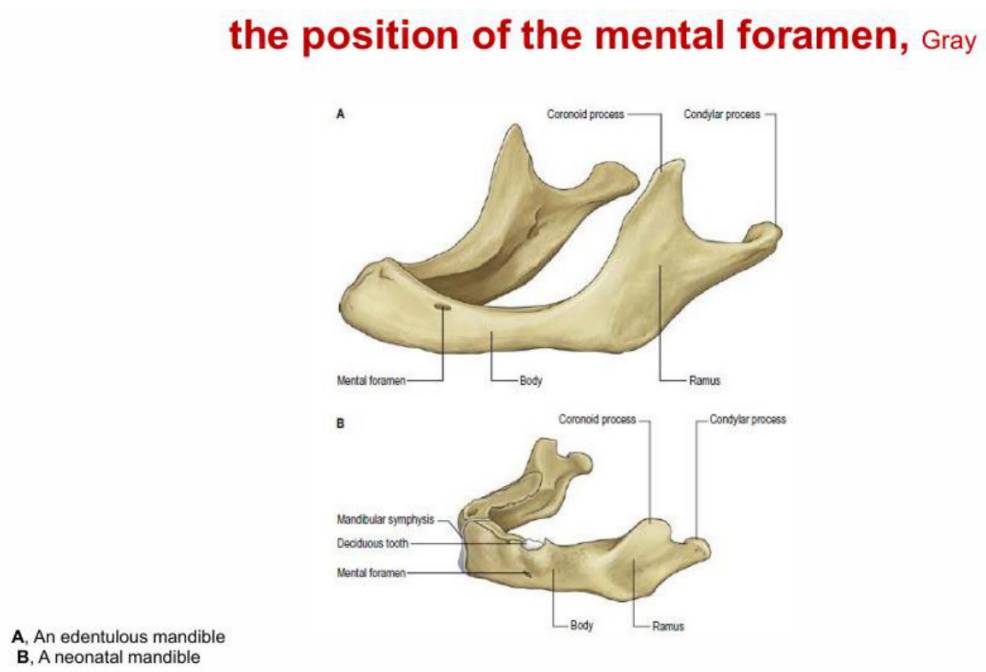
- **بعد از تولد استخوان فک تحتانی دچار چه تغییراتی می شود؟**

در زمان تولد سنفیز منتیل حاوی غضروف است بنابراین در این قسمت سلول های غضروفی اضافه می شوند و انتهای که استخوانی است استخوانی شدن انجام می شود جسم مانند یک ورقه استخوانی هستش که در آن حفرات دندانی برای دندان های شیری وجود دارد که این حفرات از هم جدا هستند و کانال مندی بولار نزدیک به کنار تحتانی جسم قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

جای سوراخ چانه در مندیبل بی‌دندان و نوزاد

جزوه درس، ص 15 · A: مندیبل بی‌دندان؛ B: مندیبل نوزاد



توضیح تکمیلی تصویر: زیر شکل A عبارت مندیبل بی‌دندان و زیر شکل B عبارت مندیبل نوزاد آمده است؛ جای سوراخ چانه در هر دو نما نشان داده شده است.

- مندیبل بی‌دندان · Edentulous mandible
- مندیبل نوزاد · Neonatal mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

استخوان سازی از بیرون انجام می شود و سوراخ منتال در زیر اولین دندان آسیای شیری قرار می گیرد در این دوره زائده کرونوئید بالای زائده کوندیلار قرار گرفته است در سه سالگی زائده کوندیلار بالا می آید و زائده ی کرونوئید در جلوی آن قرار می گیرد و سوراخ منتال هم، جهت آن به سمت عقب و خارج می شود از سال اول تا سوم بعد از تولد دو تا نیمه استخوان از طرف پایین به بالا جوش می خورند و البته در طی سال دوم قسمت بالا هنوز استخوانی نشده بنابراین در عکس های رادیولوژی باید در شکستگی در این قسمت قابل افتراق باشد و اشتباه گرفته نشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

در طول سال اول تا دوم چانه رشد پیدا می کند و جهت سوراخ منتال هم گفتیم که تغییر می کند از جهتی که به سمت جلو بوده به سمت عقب می رود و هم ارتفاع اون افزایش پیدا میکند و هم طول آن افزایش پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

- **ارتفاع جسم استخوان فک تحتانی چگونه افزایش پیدا می کند؟**

از جلو به عقب هست به این صورت است که استخوان به کنار خلفی راموس مندیبل اضافه می شود و اما از کنار قدامی استخوان بازجذب میشه یا عمل رزوشن انجام می شود بنابراین استخوان به طرف عقب گوش پیدا کرده و به طول آن اضافه می شود در زائده ی کرونوئید و زائده کوندیلار نیز به همین صورت استخوان به سمت عقب رشد پیدا کرده و طول اون زیاد می شود یعنی این که به کناره خلفی زائده ی کرونوئید و زائده کوندیلار استخوان اضافه می شود و از کنار قدامی این زوائد استخوان بازجذب می شود.

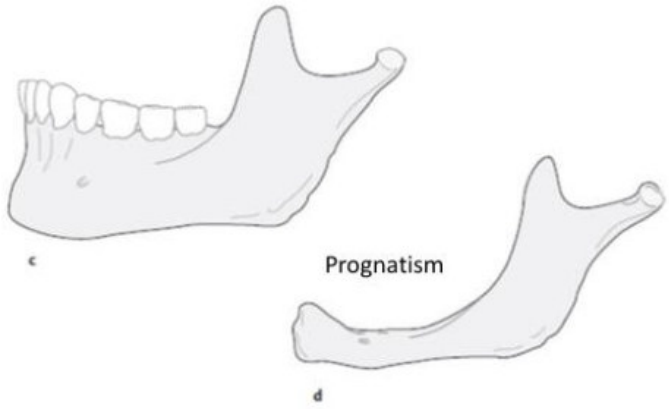
منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

در دوران بزرگسالی کانال مندی بولار در موازی خط مایلو هایوئید قرار گرفته است فک تحتانی در سن شش سالگی تقریبا به بلوغ نزدیک می شود و دو تا دندان پرمولار یا آسیای کوچک دارد اما در سن پیری که دندان ها یا به صورت طبیعی می ریزند و یا این که کشیده می شوند زائده ی آلوئولار کم کم به سمت پایین تحلیل می رود که به آن پروگناتیزم (Prognathism) گفته می شود در این صورت کانال مندی بولار و سوراخ منتال به کنار فوقانی بادی نزدیک می شوند و کانال مندی بولار هم در قسمت پایین و عقب سوراخ منتال قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 14 – رونویسی در حال مقابله

پروگناتیزم در مندیبل بی‌دندان

جزوه درس، ص 14 · مندیبل بزرگسال در برابر مندیبل بی‌دندان (Prognathism)



توضیح تکمیلی تصویر: دو طرح‌واره، فک دارای دندان و فک بی‌دندان را نشان می‌دهند؛ واژه Prognathism کنار نمای پایینی نوشته شده است.

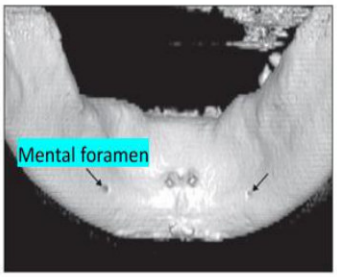
- پروگناتیزم · Prognathism
- مندیبل بی‌دندان · Edentulous mandible
- زاویه مندیبل · Angle of the mandible
- زائده کورونوئید · Coronoid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

دو تصویر فک و سوراخ چانه

جزوه درس، ص 15 · رادیوگرافی نیم‌رخ و تصویر مندیبل





توضیح تکمیلی تصویر: در نمای نیم‌رخ، فک فوقانی و تحتانی با نام نشان داده شده‌اند؛ در تصویر مقابل، فلش‌ها سوراخ‌های چانه‌ای را مشخص می‌کنند.

- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۳: تغییرات سنی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا خط استخوانی‌نشده سمفیز در رادیوگرافی کودک می‌تواند با شکستگی اشتباه شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد

مبحث ۱۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: نمای قدامی جمجمه از جلسه ۱

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار سوراخ یا بریدگی نمای قدامی و مسیر عصب بینی خارجی؛ یک جدول که بیشتر از هر متنی به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- چهار سوراخ یا بریدگی نمای قدامی و مسیر عصب بینی خارجی را نام ببرید.
- برای هر سوراخ عصب و عروق عبوری را بگویید.
- تفاوت سوراخ سوپرااوربیتال و ناچ (Notch) را توضیح دهید.

کلیدواژه

Supraorbital foramen · Infraorbital foramen · Zygomaticofacial · Mental foramen · External nasal nerve

جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۵۵

ساختارهایی که از درون سوراخ های نمای فرونتالیس (Norma frontalis) عبور می کند شامل:

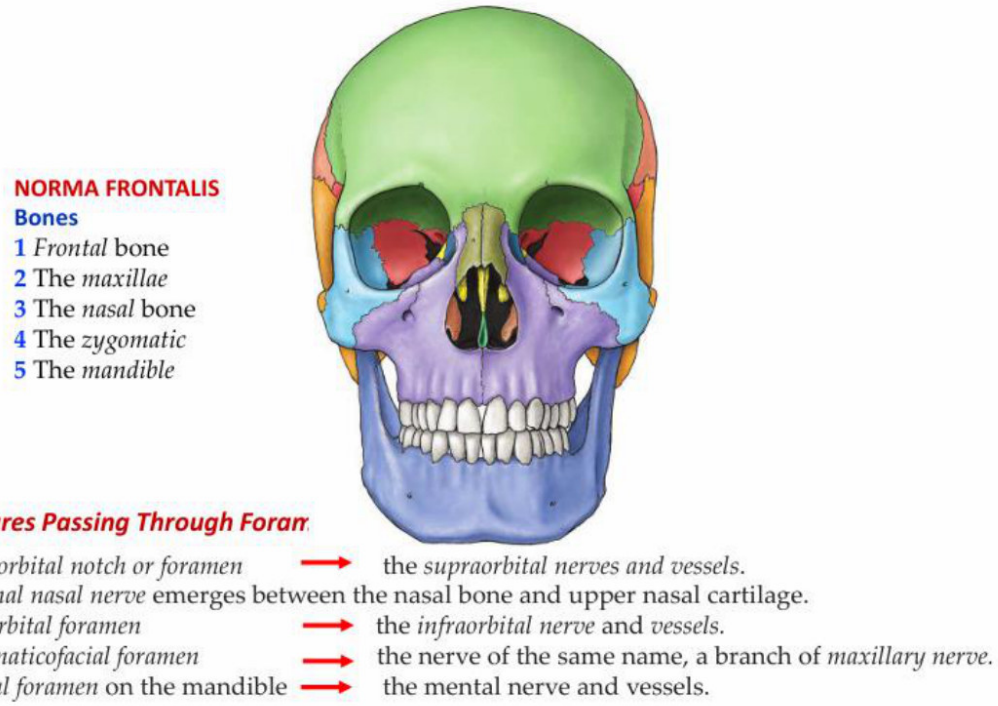
منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

- از سوراخ سوپرا اوربیتال (Sopraorbital foramen): Sopraorbital nerves and vessels)
- از حد فاصل بین کنار تحتانی استخوان های بینی و غضروف فوقانی بینی: عصب اکسترنال نازال (External nasal nerve)
- سوراخ اینفرا اوربیتال (Infraorbital foramen): Infraorbital nerves and vessels)
- سوراخ زایگوماتیک فیشیال (Zygomaticofacial foramen): Zygomaticofacial nerves؛ شاخه ای از شریان ماگزیلایی
- سوراخ منتال یا چانه ای (Mental foramen): Mental nerves and vessels)

منبع: متن جزوه درس، ص 16 — رونویسی در حال مقابله

سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد

جزوه درس، ص 16 · نمای قدامی جمجمه با پنج مسیر و فهرست محتویات



توضیح تکمیلی تصویر: این تصویر پنج مسیر را فهرست می‌کند: ناچ یا سوراخ سوپرااوربیتال و سه سوراخ صورت. مسیر عصب بینی خارجی بین استخوان و غضروف بینی است؛ مسیرهای دیگر از سوراخ‌ها یا ناچ عبور می‌کنند.

- ناچ/سوراخ سوپرااوربیتال · Supraorbital notch/foramen
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infraorbital foramen
- سوراخ گونه‌ای‌چهره‌ای · Zygomaticofacial foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen
- استخوان بینی · Nasal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

نمای قدامی جمجمه و محل سوراخ‌های صورت در گری

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · شکل ۸.۱۸ گری، نمای قدامی

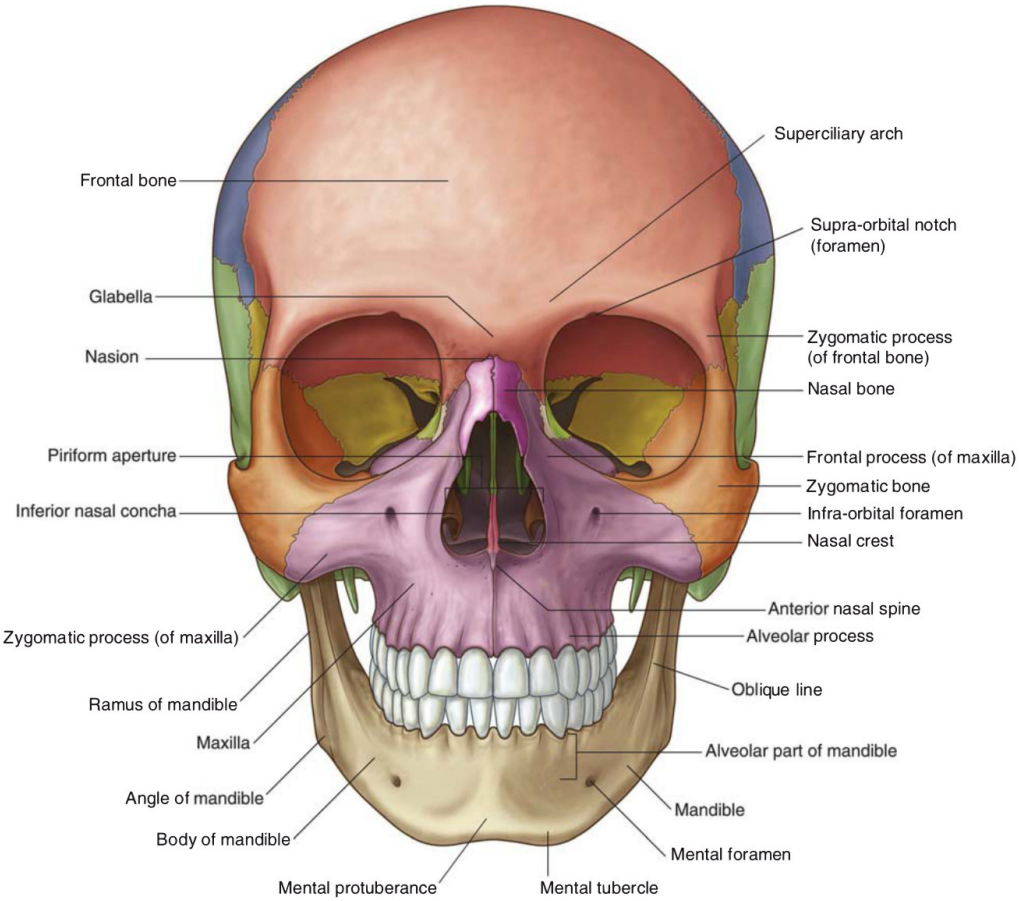


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Anterior view of the skull.

توضیح تکمیلی تصویر: در شکل گری، ناچ یا سوراخ سوپرااوربیتال، سوراخ اینفرااوربیتال و سوراخ چانه دیده می‌شوند؛ برای محتویات آن‌ها به جدول جزوه مراجعه کنید.

- ناچ/سوراخ سوپرااوربیتال · Supra-orbital notch (foramen)
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infra-orbital foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۴: سوراخ‌های نمای قدامی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۵۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا سوراخ سوپرااوربیتال در بعضی جمجمه‌ها به‌شکل ناچ است و نه سوراخ کامل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی

مبحث ۱۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۷ · پیش‌نیاز: سوراخ‌های نمای قدامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

همان سوراخ‌ها، این‌بار با فاصله از خط وسط و دامنه تغییرات؛ چیزی که روی بیمار به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- فاصله تقریبی هر سوراخ از خط وسط صورت را بگویید.
- هم‌راستایی سوراخ اینفرااوربیتال با دندان پنجم را توضیح دهید.
- دامنه تغییرات سوراخ چانه را بیان کنید.

کلیدواژه

Surface anatomy · Midline · Infraorbital foramen · Mental foramen

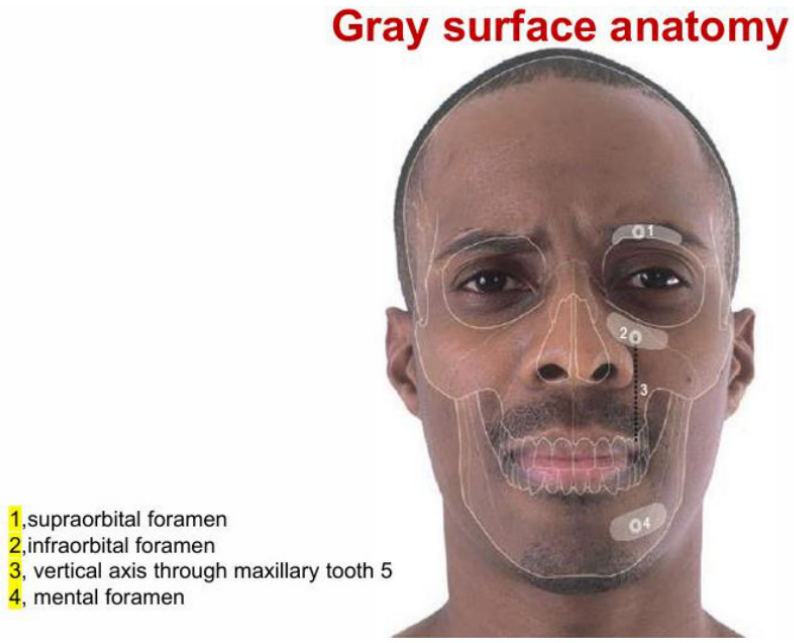
جزوه درس، ص ۱۵ و ۱۷

سوراخ ها و عروق اعصاب عبوری از آن ها در نمای قدامی در آناتومی سطحی به این صورت قرار گرفته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 17 — رونویسی در حال مقابله

آناتومی سطحی سوراخ‌های صورت

جزوه درس، ص 17 · صورت بیمار با محل سه سوراخ و دامنه تغییراتشان



توضیح تکمیلی تصویر: نقاط شماره‌دار صورت و راهنمای سوراخ‌های فوق‌کاسه‌ای، زیرکاسه‌ای و چانه‌ای در تصویر آمده‌اند.

- سوراخ سوپرااوربیتال · Supraorbital foramen
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infraorbital foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

ناحیه قرارگیری سوراخ سوپرا اوربیتال و دسته عصبی عروقی ناحیه سفید تقریبا سه سانتی متر از خط وسط فاصله دارد ناحیه قرارگیری سوراخ اینفرو اوربیتال و دسته عصب عروقی آن، که ناحیه سفید است حدود دو و نیم سانتی متر از خط وسط فاصله دارد و این سوراخ با یک محور عمودی از دندان شماره پنج فک بالا یا ماگزیلا (Maxilla) که عبور می کند هم راستا است.

منبع: متن جزوه درس، ص 17 — رونویسی در حال مقابله

در این تصویر ناحیه چهار مربوط به ناحیه قرار گیری سوراخ منتال و دسته عصبی عروقی آن ناحیه سفید رنگ حدود دو و نیم سانتی متر از خط میانی صورت فاصله دارد که بین اپکس ریشه های دندان های چهار و پنج قرار می گیرد که تقریبا دامنه ی تغییرات بین دندان های سه تا شش می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 17 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۵: آناتومی سطحی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵ و ۱۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا دامنه تغییرات سوراخ چانه را از دندان سه تا شش می‌گویند و این برای بی‌حسی چه پیامی دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی

مبحث ۱۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۱۹ · پیش‌نیاز: نمای طرفی جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نمای طرفی، نمای اصلی این جلسه است و استخوان گیجگاهی پرکارترین استخوان آن.

اهداف یادگیری

- هفت استخوانی را که در نمای طرفی دیده می‌شوند نام ببرید.
- چهار بخش استخوان گیجگاهی را با محتوای هر کدام بگویید.
- کنار فوقانی گیجگاهی و دو درز آن را بشناسید.

کلیدواژه

Norma temporalis · Squamous part · Tympanic part · Styloid process · Petrous part · Mastoid

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · گری، ص ۸۵۸ · نتر، پلیت ۳۸

• نمای طرفی جمجمه یا گیجگاهی (Norma Temporalis)

در این نما استخوان هایی که مشاهده میشه شامل:

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

- استخوان فک فوقانی یا Maxilla
- استخوان گونه ای و قوس گونه ای یا Zygomatic
- استخوان فک تحتانی یا Mandible که شامل Coronoid process of mandible و Condylar process of mandible هست
- بال بزرگ استخوان Sphenoid یا شاپره ای
- بخشی از استخوان پیشانی یا Frontal و بخشی از استخوان آهیانه یا Parietal
- استخوان گیجگاهی یا Temporal

- بخشی از استخوان پس سری یا Occipital

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

نمای طرفی جمجمه با رنگ هر استخوان

جزوه درس، ص 18 · Norma temporalis؛ استخوان‌های سازنده دیواره طرفی



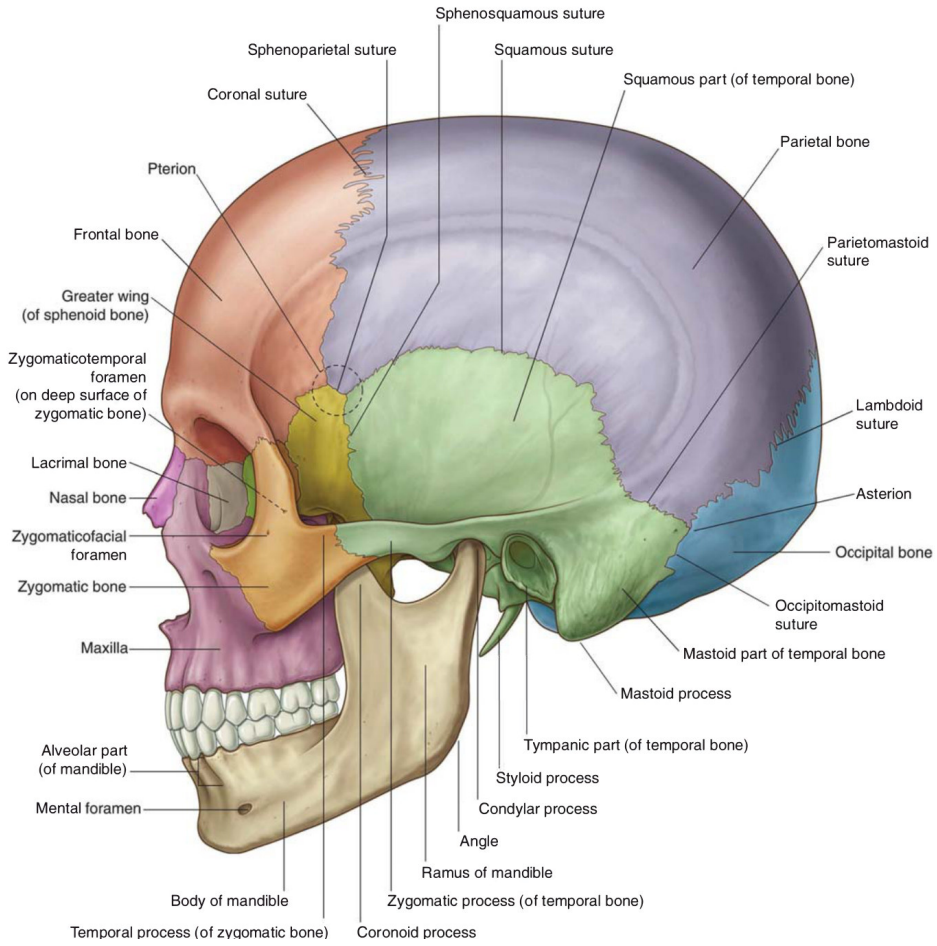
توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی جمجمه، استخوان‌ها با رنگ‌های مختلف از هم جدا شده‌اند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

نمای طرفی جمجمه در گری

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · شکل ۸.۱۹ گری



Lateral view of the skull.

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی گری، استخوان‌ها، چند درز، پتریون و آستریون با خط راهنما نام‌گذاری شده‌اند.

- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز تاجی · Coronal suture
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

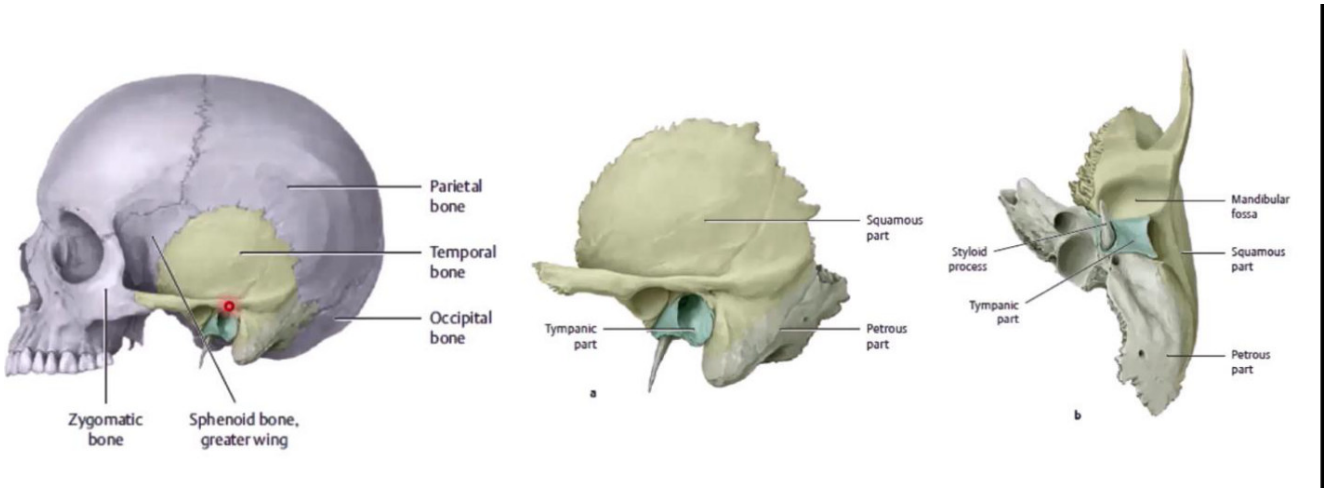
ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

در این جلسه استخوان گیجگاهی و آهیانه ای توضیح داده می شود: Temporal به وقت یا گذر زمان و سفید شدن موهای شقیقه اشاره دارد و از استخوان های زوج سر می باشد که در پایین و طرفین جمجمه قرار گرفته است. از 4 بخش تشکیل شده است که در شکل اول از سمت راست، نمای تحتانی و در شکل وسط، نمای طرفی آن ها مشاهده می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

چهار بخش استخوان گیجگاهی

جزوه درس، ص 19 · جمجمه و دو نمای استخوان گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: در نمای جمجمه جای استخوان گیجگاهی و در دو نمای کناری بخش‌های صدفی، تیمپانیک، خاره‌ای و زائده استایلوئید برچسب دارند.

- بخش صدفی · Squamous part
- بخش تیمپانیک · Tympanic part
- زائده استایلوئید · Styloid process
- بخش خاره‌ای · Petrous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

- **1. صدف یا Squamous**

سطح آن محدب است. دارای 2 بخش می باشد: یک بخش عمودی و یک زائده افقی Zygomatic است که این زائده به سمت زائده تمپورال استخوان گونه ای رفته و باهم قوس گونه ای را تشکیل می دهند.

منبع: متن جزوه درس، ص 18 — رونویسی در حال مقابله

بالای مجرای شنوایی گوش بیرونی یک ناودانی به سمت بالا می رود که به آن Groove for posterior deep temporal artery می گویند. (شیار برای شریان تمپورال میانی). قسمتی از صدف در تشکیل حفره تمپورال شرکت می کند که به این قسمت عضله Temporalis متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

بین صدف و بخش Mastoid درز صدفی پستانی یا Squamomastoid suture وجود دارد که از این درز به سمت عقب بخش Mastoid شروع می شود، البته ممکنه این درز وجود نداشته باشه و کاملا صاف شده باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

۱ 2. بخش سوماخی یا Tympanic part: مجرای گوش بیرونی را تشکیل می دهد که به آن External acoustic meatus می گویند.

۲ 3. Styloid process یا زائده استایلوئید

۳ 4. بخش خاره ای یا پستانی یا Petrous part

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

استخوان گیجگاهی دارای یک کنار فوقانی هست که از جلو با بال بزرگ استخوان Sphenoid و از بالا و عقب با استخوان Parietal مفصل می شود و درز Squamous را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 19 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۶: نمای گیجگاهی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · گری، ص ۸۵۸ · نتر، پلیت ۳۸

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا استخوان گیجگاهی هم در قاعده جمجمه شریک است و هم در دیواره طرفی؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی

مبحث ۱۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۱ · پیش‌نیاز: راموس و زائده کندیلار

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حرکت فک، داستان لغزیدن یک کندیل روی یک برجستگی است؛ دررفتگی همان داستان با یک قدم اضافه.

اهداف یادگیری

- برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی را از هم جدا کنید.
- مسیر حرکت کندیل در باز کردن دهان را توضیح دهید.
- روش جااندازی دررفتگی حاد را بیان کنید.

کلیدواژه

Articular tubercle · Mandibular fossa · Condyle · Dislocation · Postglenoid tubercle

جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ · نتر، پلیت ۴۲

قوس گونه ای دارای دو ریشه هست: ریشه خلفی که کنار خلفی آن به سمت بالا ستیغ Supra mastoid را تشکیل می دهد. 1.5 سانتی متر زیر این درز، درز Squamo mastoid قرار دارد.

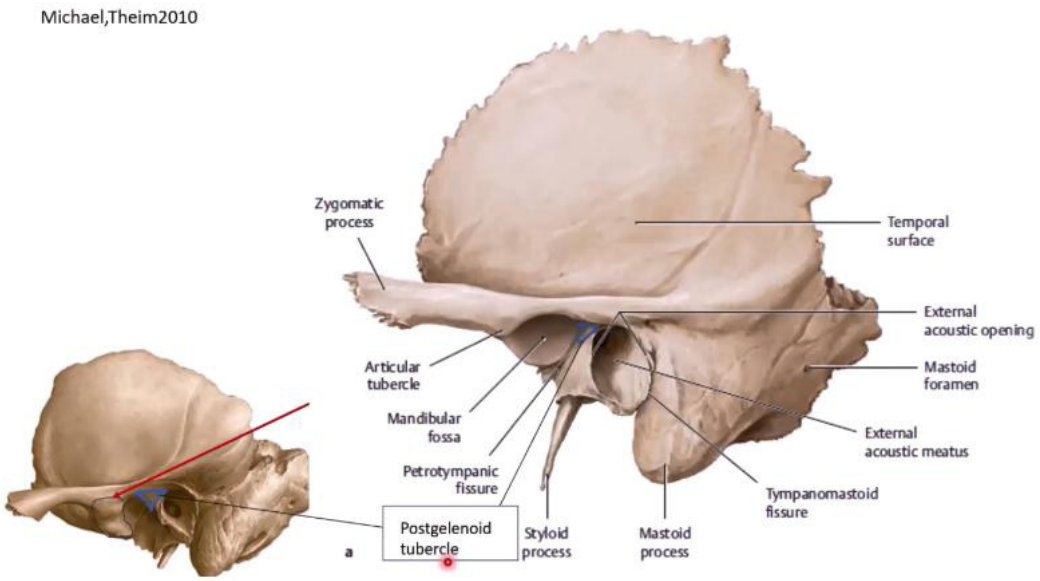
منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

در تصویر ریشه قدامی قوس گونه ای را مشاهده می کنید که به صورت عرضی قرار گرفته و Articular tubercle یا برجستگی مفصلی را ایجاد کرده که به صورت یک نیم استوانه است و از قسمت قدام به خلف به صورت محدب است. این برجستگی در جلوی حفره Mandibular قرار گرفته و با زائده مفصلی یا Articular Process استخوان فک تحتانی مفصل می شود که مفصل TNG یا Temporal Mandibular Joint می باشد. Condylar process of mandible هنگام حرکات فک با برجستگی مفصلی ارتباط پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 — رونویسی در حال مقابله

برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی

جزوه درس، ص 20 · نمای طرفی استخوان گیجگاهی؛ برجستگی و حفره مفصلی



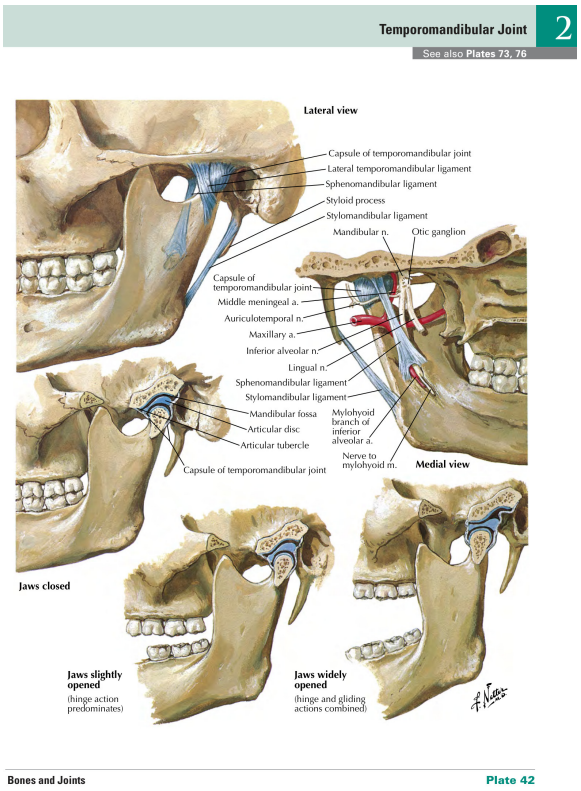
توضیح تکمیلی تصویر: حفره فک تحتانی، برجستگی مفصلی و تکمه پس‌گلنوئیدی در تصویر با خطوط راهنما مشخص شده‌اند.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- تکمه پس‌گلنوئیدی · Postglenoid tubercle
- زائده استایلوئید · Styloid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 20

مفصل گیجگاهی‌مندیبلی و رباط‌هایش در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۲، ص ۹۴ · پلیت ۴۲ نتر



Temporomandibular Joint

توضیح تکمیلی تصویر: پلیت نتر همان مفصل را با کپسول، دیسک و رباط‌ها نشان می‌دهد؛ برای فهم دررفتگی، همین کپسول و رباط‌ها هستند که محدودکننده حرکت‌اند.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- دیسک مفصلی · Articular disc
- کپسول · Capsule
- رباط طرفی · Lateral ligament
- رباط استایلومندیبولار · Stylomandibular ligament

ارجاع متن: نتر، پلیت 42

- **اهمیت بالینی برجستگی مفصل**

هنگام باز کردن دهان Condyle فک تحتانی از حفره فک تحتانی به سمت جلو حرکت می کند و روی این برجستگی می لغزد، بنابراین این برجستگی مسیر حرکت مفصل را مشخص می کند. جهت جلوگیری نسبی از جا به جایی خلفی Condyle حائز اهمیت هست و وجود این برجستگی کمک می کند که Condyle در محیط مفصلی پایدار بماند و حرکتش در مسیر طبیعی حفظ شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 20 – رونویسی در حال مقابله

اگر Condyle فک تحتانی از روی برجستگی مفصلی عبور کند و در جلوی آن قرار بگیرد در این صورت به آن در رفتگی مفصل TNG می گویند که بیمار نمی تواند دهان خود را ببندد. در رفتگی حاد آن با جا اندازی دستی درمان می شود به این صورت که پزشک رو به روی بیمار می ایستد و شست خود را روی راموس فک تحتانی قرار می دهد و سایر انگشتان در زیر لبه ی تحتانی فک تحتانی قرار می دهد و ابتدا به سمت پایین فشار می دهد تا Condyle از جلوی برجستگی مفصلی آزاد بشه، سپس فک به سمت عقب هدایت می شود. در پایان فک باید به سمت بالا برگردد تا در جای طبیعی خود قرار بگیرد.

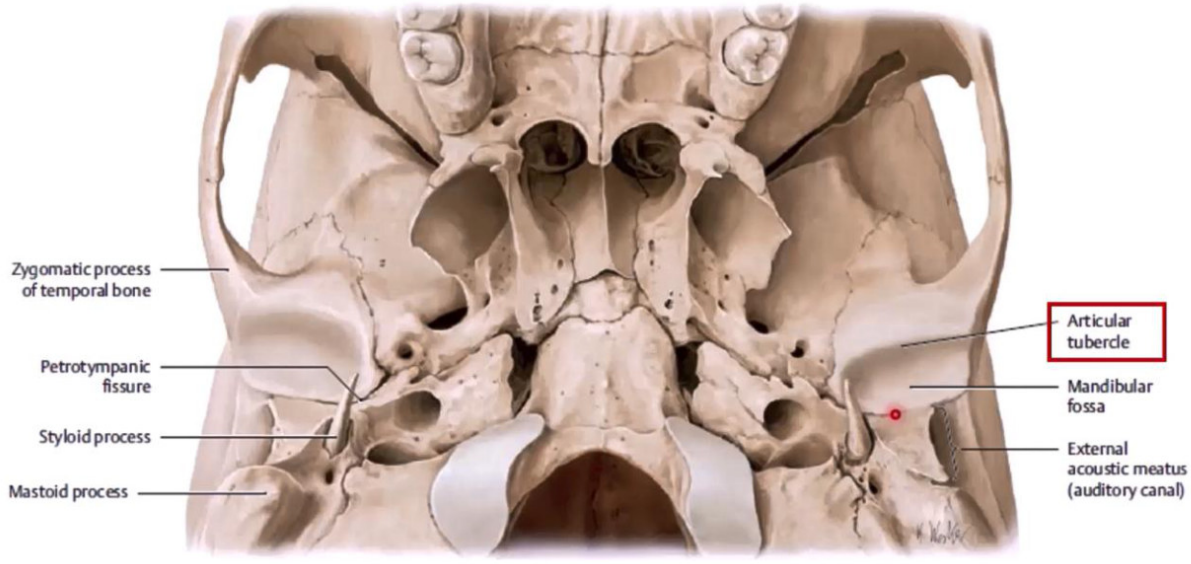
منبع: متن جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ – رونویسی در حال مقابله

برجستگی دیگری در سمت خلفی مجرای گوش بیرونی قرار گرفته که به آن Post glenoid Tubercle می گویند که اجازه عقب رفتن به Condyle نمی دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

مفصل گیجگاهی‌مندیبلی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 21 · نمای تحتانی قاعده جمجمه؛ حفره فک تحتانی و زوائد اطراف آن



توضیح تکمیلی تصویر: از پایین، روابط روشن‌تر است: حفره فک تحتانی، برجستگی مفصلی، زائده استایلوئید و ماستوئید در یک نگاه دیده می‌شوند.

- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- زائده استایلوئید · Styloid process
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- سوراخ بیضی · Foramen ovale

ارجاع متن: جزوه درس، ص 21

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۷: برجستگی مفصلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ · نتر، پلیت ۴۲

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا در دررفتگی جلو، بیمار نمی‌تواند دهان را ببندد اما می‌تواند بازتر کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی

مبحث ۱۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۱–۲۵ · پیش‌نیاز: چهار بخش استخوان گیجگاهی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش‌های دیگر گیجگاهی: شکاف‌ها، تیغه‌ها، تیمپانیک، پتروس، استایلوئید، ماستوئید و مثلث بالای مجرا.

اهداف یادگیری

- شکاف صدفی‌تیمپانیک و دو درز ساخته‌شده از آن را توضیح دهید.
- بخش تیمپانیک و دو سطح آن را توصیف کنید.
- اضلاع مثلث سوپرامیاتال و اهمیت بالینی آن را بگویید.

کلیدواژه

Squamotympanic fissure · Tegmen tympani · Suprameatal triangle · Mastoid antrum · Stylomastoid foramen

جزوه درس، ص ۲۲–۲۵ · نتر، پلیت ۴۲

در شکل Articular Tubercle از نمای تحتانی جمجمه و صدف قابل مشاهده است. بخش تحتانی صدف یک بخش مستطیلی شکل دارد که این قسمت بخشی از حفره Infratemporal را تشکیل می دهد. همچنین در این بخش حفره فک تحتانی نیز مشاهده می شود که Condylar process of mandible هم در این قسمت قرار می گیرد که مفصل TNG را تشکیل می دهد.

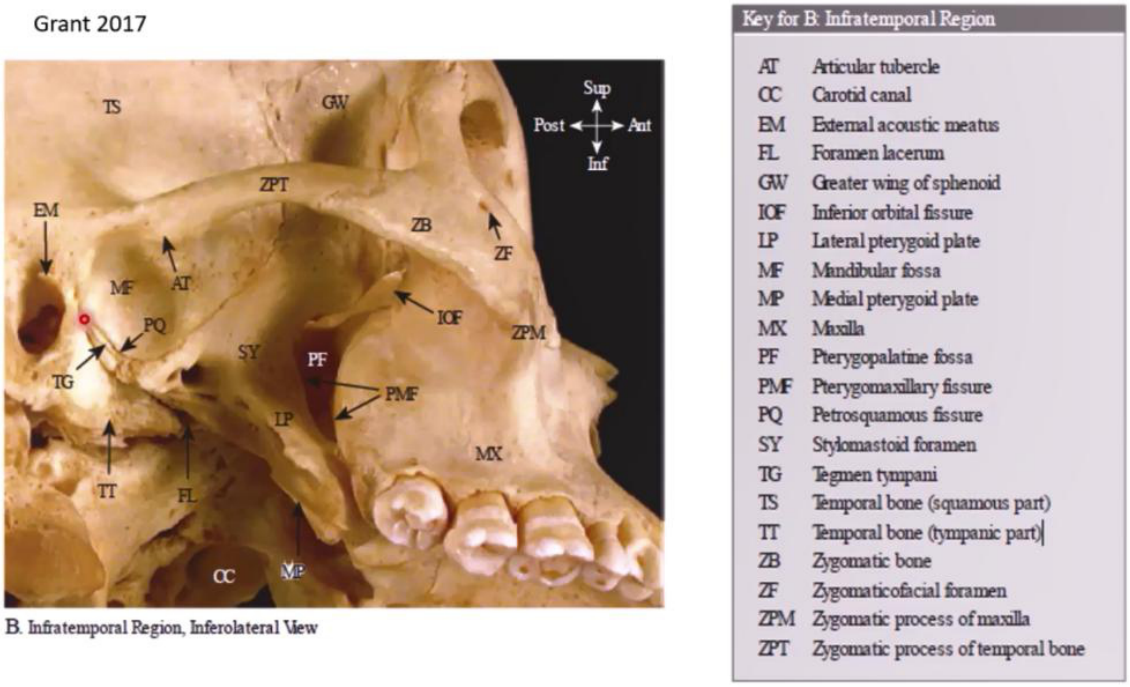
منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

در قسمت خلفی حفره فک تحتانی و قسمت Tympanic به خصوص در قسمت داخل یک شکاف به نام Squamo tympanic Fissure یا درز گلایزر وجود دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21 — رونویسی در حال مقابله

ناحیه زیرگیجگاهی و کلید نام‌ها

جزوه درس، ص 22 · Infratemporal region از نمای تحتانی-طرفی (Grant 2017) با کلید برچسب‌ها



B. Infratemporal Region, Inferolateral View

Key for B: Infratemporal Region	
AT	Articular tubercle
CC	Carotid canal
EM	External acoustic meatus
FL	Foramen lacerum
GW	Greater wing of sphenoid
IOF	Inferior orbital fissure
LP	Lateral pterygoid plate
MF	Mandibular fossa
MP	Medial pterygoid plate
MX	Maxilla
PF	Pterygopalatine fossa
PMF	Pterygomaxillary fissure
PQ	Petrosquamous fissure
SY	Stylomastoid foramen
TG	Tegmen tympani
TS	Temporal bone (squamous part)
TT	Temporal bone (tympanic part)
ZB	Zygomatic bone
ZF	Zygomaticofacial foramen
ZPM	Zygomatic process of maxilla
ZPT	Zygomatic process of temporal bone

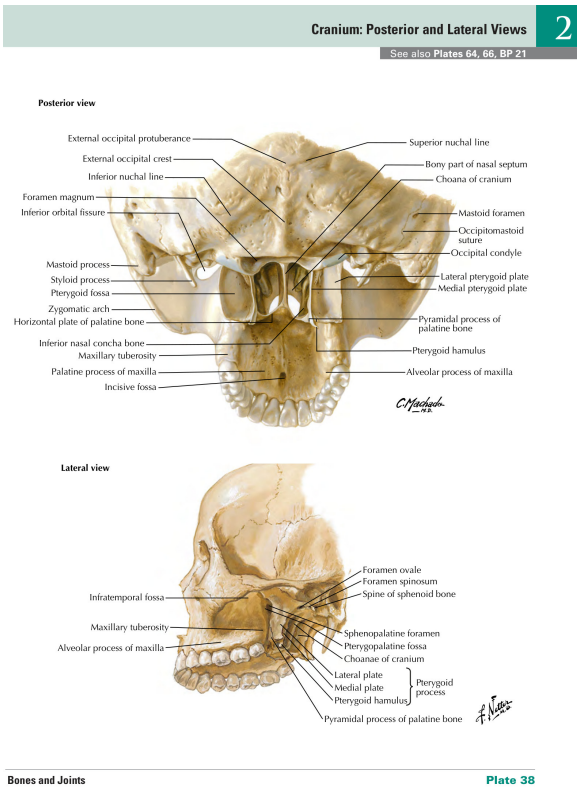
توضیح تکمیلی تصویر: عکس ناحیه زیرگیجگاهی همراه با کلید اختصارات در همان تصویر منبع آمده است؛ برای تطبیق هر حروف به کلید کنار عکس مراجعه کنید.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- شکاف پتروسکواموس · Petrosquamous fissure
- تگمن تیمپانی · Tegmen tympani
- سوراخ استایلوماستوئید · Stylomastoid foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

حفره زیرگیجگاهی و اطراف آن در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۸، ص ۹۰ · پلیت ۳۸ نتر



Cranium: Posterior and Lateral Views

توضیح تکمیلی تصویر: پلیت دو نمای خلفی و طرفی را نشان می‌دهد؛ در نمای طرفی حفره زیرگیجگاهی، سوراخ‌های بیضی و خاری و زائده پتریگوئید برچسب دارند.

- حفره زیرگیجگاهی · Infratemporal fossa
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum
- زائده پتریگوئید · Pterygoid process

ارجاع متن: نتر، پلیت 38

اگر این شکاف را به سمت خارج ادامه بدهیم قسمت صدف و بخش Tympanic به هم جوش می خورند و در این قسمت Post glenoid Tubercle را تشکیل می دهند که در حیوانات به دلیل اینکه کف قاعده جمجمه تخت هست مانع از به عقب آمدن فک تحتانی می شود اما در انسان به صورت یک برجستگی باقی مانده است.

منبع: متن جزوه درس، ص 22 – رونویسی در حال مقابله

بین حفره فک تحتانی و بخش تیمپانیک در این قسمت تیغه Tegman tympanic هست که درز Squamotympanic را به دو درز دیگر تبدیل میکند: Petro squamous که در قسمت جلوی تیغه قرار گرفته و از آن چیزی عبور نمی کند و Petrotympanic که در قسمت عقب این تیغه واقع شده است که رباط چکشی قدامی یا Anterior malleolar ligament و شریان سوماخی قدامی یا Anterior Tympanic Artery و در داخل هم، عصب Chorda Tympanic از عصب زوج 7 مغزی، عبور می کند.

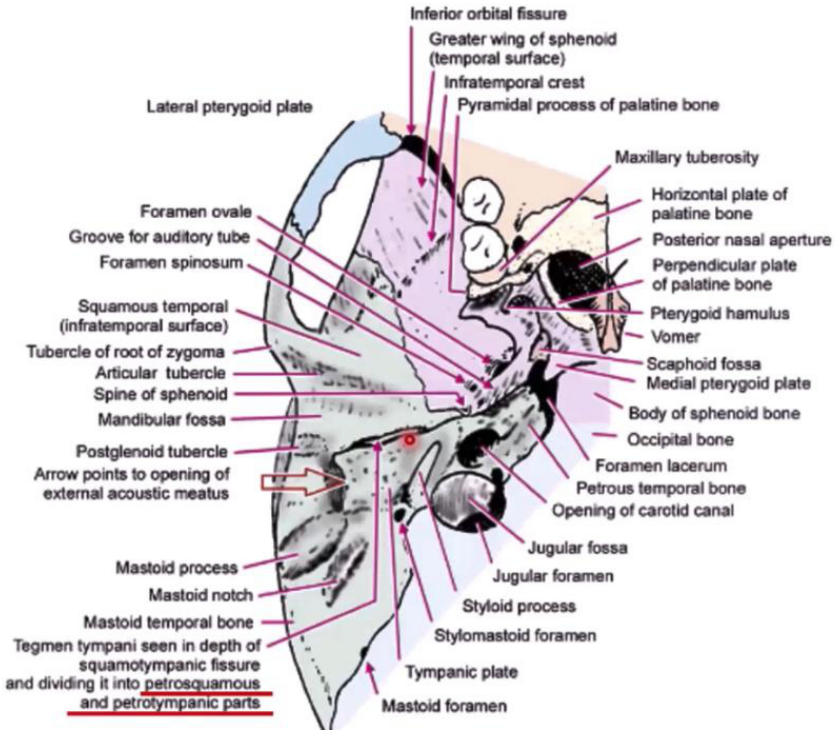
منبع: متن جزوه درس، ص 22 – رونویسی در حال مقابله

Tegmen به معنی سقف و Tympanic صندوق سوماخ هست که مربوط به حفره گوش میانی می باشد. این تیغه در تصویر به سمت درز اسکواموتیمپانیک مشاهده می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 22 – رونویسی در حال مقابله

سوراخ‌های قاعده جمجمه از نمای عمقی

جزوه درس، ص 22 · نمای عمقی قاعده جمجمه با سوراخ بیضی، خاردار، لاسروم و سوراخ‌های گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: در این نما سوراخ‌های بیضی، خاری و پاره و نیز درزهای پتروسکواموس و پتروتیمپانیک برچسب دارند.

- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاردار · Foramen spinosum
- سوراخ لاسروم · Foramen lacerum
- حفره ژوگولار · Jugular fossa
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- سوراخ استایلوبید · Stylomastoid foramen

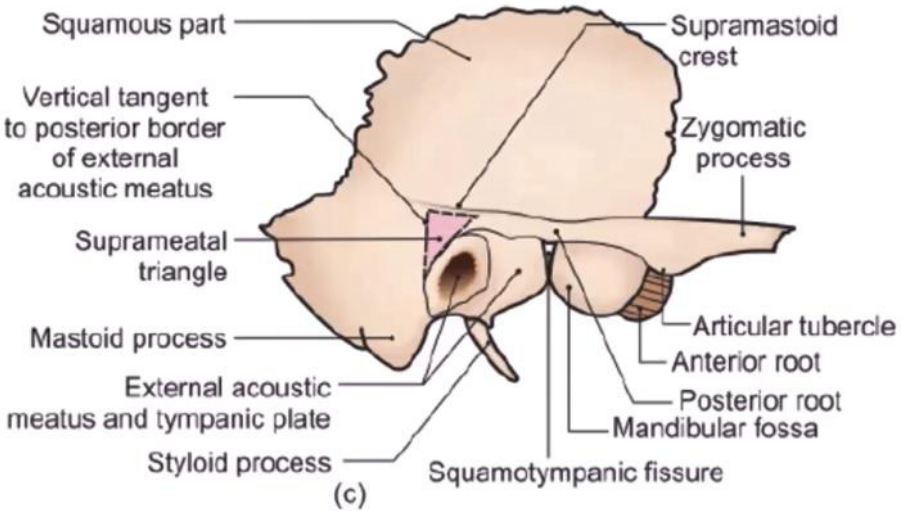
ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

در پایین supramastoid crest یه مثلثی به اسم Suprameatal triangle یا حفره ی فوق مجرایی وجود دارد. اجزای این مثلث شامل در بالا supramastoid crest و در پایین یک چهارم خلفی فوقانی مجرای گوش بیرونی اگر این مجرا را به چهار قسمت تقسیم کنیم یک چهارم خلفی فوقانی مجرا از اعضای تشکیل دهنده این مثلث می باشد و ضلع دیگر آن Vertical tangent یا خط عمودی که به خلف مجرای گوش بیرونی مماس می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 23 — رونویسی در حال مقابله

بخش صدفی و زائده ماستوئید

جزوه درس، ص 23 · نمای طرفی استخوان گیجگاهی و مثلث سوپرامیاتال



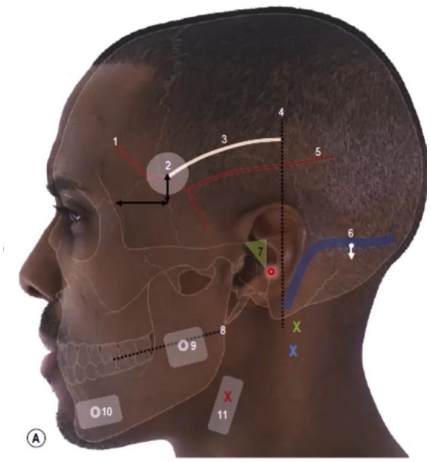
توضیح تکمیلی تصویر: بخش صدفی، زائده ماستوئید و مثلث سوپرامیاتال در تصویر نام‌گذاری شده‌اند.

- بخش صدفی · Squamous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- مثلث سوپرامیاتال · Suprameatal triangle
- ستیغ سوپراماستوئید · Supramastoid crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 23

مثلث سوپرامیاتال روی سر

جزوه درس، ص 23 · نمای طرفی سر با نقاط شماره‌دار



توضیح تکمیلی تصویر: نقاط و خطوط آناتومی سطحی روی سر مشخص شده‌اند؛ خود تصویر برای تطبیق شماره‌ها به متن و منبع اصلی ارجاع می‌دهد.

- مثلث سوپرامیاتال · Suprameatal triangle
- ستیغ سوپراماستوئید · Supramastoid crest
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus
- خط عمودی مماس · Vertical tangent

ارجاع متن: جزوه درس، ص 23

در صورت عفونت گوش 1.25 سانتی متر در عمق این Suprameatal triangle، انتروم ماستوئید قرار گرفته که از این طریق می تواند دسترسی به گوش میانی پیدا کنند. این نما برای استخوان Tymporal سمت راست است و همین موارد را بر روی استخوان Tymporal سمت چپ هم مشاهده کنید که در آناتومی سطحی در این قسمت اضلاع مثلث قرار می گیرند.

منبع: متن جزوه درس، ص 23 — رونویسی در حال مقابله

Tympanic part یک ورقه ی خمیده ای است که بین Petrous Part و صدف استخوان قرار گرفته در قسمت قدام آن صدف و در قسمت خلف زائده ی ماستوئید قرار گرفته و در قسمت داخل Petrous استخوان Tymporal واقع شده است. دارای دو تا سطح قدامی و خلفی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۲۳–۲۴ — رونویسی در حال مقابله

سطح خلفی: جدار قدامی، کف و نیمه تحتانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی را تشکیل می دهد. سطح قدامی در تشکیل حفره مفصلی شرکت می کند. لازم به ذکر است که نیمه فوقانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی از بخش صدف (Squamous Part) تشکیل شده است سطح قدامی بخش Tympanic دارای دو تا کنار فوقانی و تحتانی است و این سطح گود است و قسمتی از غده پاراتید در آن قرار می گیرد. حفره Mandibular از یک بخش مفصلی و یک بخش زبر و خشن به نام Tympanic تشکیل شده است.

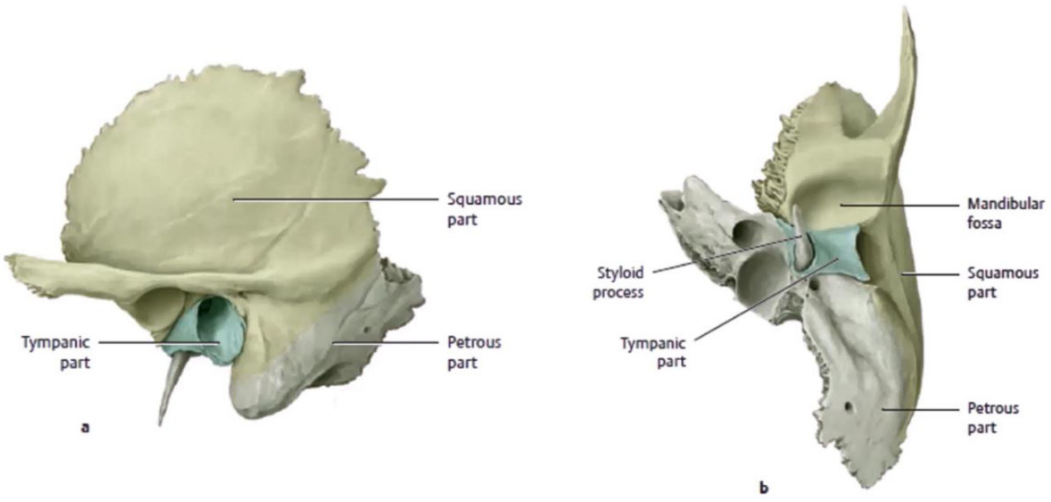
منبع: متن جزوه درس، ص 24 — رونویسی در حال مقابله

کنار تحتانی Tympanic part در این نما که نمای تحتانی است شامل دو تا تیغه لترال و میدیال می شود که به سمت خلف آمده و زائده واژینالیس (ناحیه پوشاننده هم نام گذاری می شود چون اطراف زائده استایلوئید (Styloid Process) را پوشانده است) و Styloid Process را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 24 — رونویسی در حال مقابله

بخش تیمپانیک و خاره‌ای

جزوه درس، ص 24 · دو نمای استخوان گیجگاهی؛ تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید



توضیح تکمیلی تصویر: در دو نما قسمت‌های صدفی، تیمپانیک، پتروس، زائده استایلوئید و حفره مندیبولار برچسب دارند.

- بخش تیمپانیک · Tympanic part
- بخش خاره‌ای · Petrous part
- بخش صدفی · Squamous part
- زائده استایلوئید · Styloid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 24

بخش بعدی استخوان Styloid Process است که در نمای طرفی و نمای تحتانی قابل مشاهده است به شکل نیزه ای است که به سمت پایین می آید و تعقری در سمت جلو و داخل دارد نوک به سمت پایین است و به آن عضلات و رباط هایی متصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 25 – رونویسی در حال مقابله

بین Styloid Process و mastoid Process استخوان، سوراخی به نام Stylomastoid foramen وجود دارد از Stylomastoid foramen عصب فاسیول عبور می کند و همچنین شاخه شریانی Stylomastoid که شاخه ای از پوستریو اریکولار یا گوش خلفی که آن هم شاخه ای از شریان Occipital است عبور می کند در طرف خارج زائده ی استایلوئید غده ی بزاقی پاروتید قرار گرفته است از نوک آن از سمت خارج شریان کاروتید اکسترن عبور می کند عصب فاسیال از روی قسمت اول آن یا ریشه ی آن عبور می کند بین Styloid Process و ورید ژیگولار دوانی عضله استایلو فارنژیوس عبور می کند در مجاورت Styloid مهم می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 25 – رونویسی در حال مقابله

بخش بعدی استخوان بخش Petromastoid است که Petrous Part یا خاره در نما های دیگر توضیح داده خواهد شد. قسمت زائده ی ماستوئید (mastoid Process) در نمای کناری (Lateral) قابل مشاهده است که به صورت مخروط وارونه است یعنی قاعده آن در بالا و رأس آن در پایین قرار گرفته است و در سطح بیرونی سوراخی به اسم mastoid foramen وجود دارد که یک شاخه از شریان Occipital از آن عبور می کند. mastoid Process دارای دو تا کنار فوقانی و خلفی است که کنار فوقانی تقریبا ضخیم و دندانه دار است و با (Parietal bone) مفصل می شود. کنار خلفی هم با استخوان پس سری (Occipital bone) مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 25 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۸: شکاف‌ها و زوائد — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۲–۲۵ · نتر، پلیت ۴۲

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا در ضربه به بخش تیمپانیک، خون‌ریزی از گوش علامت مهمی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی

مبحث ۱۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۵–۲۷ · پیش‌نیاز: کالواریا از جلسه ۱

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

آهیانه سقف و دیواره طرفی را می‌بندد و دو خط آن، محل اتصال فاسیا و عضله گیجگاهی است.

اهداف یادگیری

- چهار کنار و چهار زاویه آهیانه را با درز یا استخوان مقابلشان بگویید.
- برجستگی آهیانه‌ای را تعریف کنید.
- دو خط گیجگاهی و اتصال هر کدام را از هم جدا کنید.

کلیدواژه

Parietal bone · Coronal suture · Lambdoid suture · Sagittal suture · Parietal tuberosity · Temporal lines

جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ · گری، ص ۸۶۰

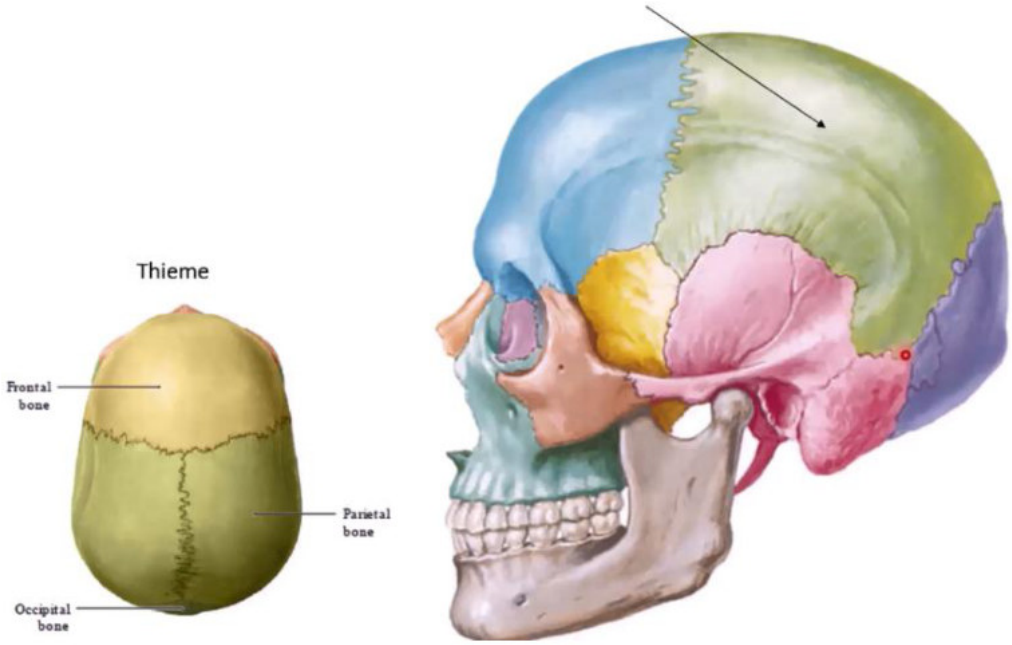
• استخوان آهیانه ای (Parietal bone)

استخوان بعدی که در نمای خلفی جمجمه دیده می شود استخوان آهیانه ای (Parietal bone) است که در تشکیل سقف و جداره های طرفی جمجمه شرکت می کند استخوان Parietal بین استخوان Frontal در قسمت قدام و استخوان پس سری در ناحیه خلفی قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 26 — رونویسی در حال مقابله

جای استخوان آهیانه در جمجمه

جزوه درس، ص 25 · نماهای فوقانی و طرفی جمجمه



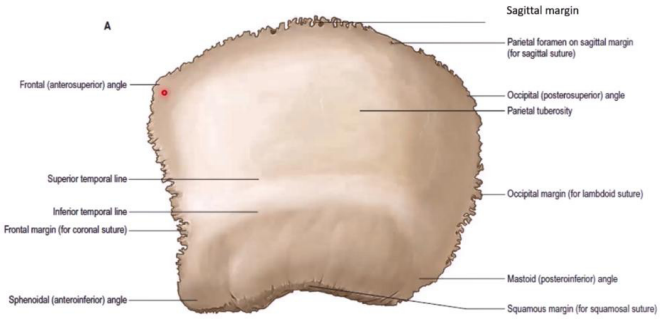
توضیح تکمیلی تصویر: در تصویر جزوه، استخوان آهیانه در نمای فوقانی نام‌گذاری و در نمای طرفی با پیکان مشخص شده است.

- استخوان آهیانه · Parietal bone
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 25

استخوان آهیانه از سطح بیرونی

جزوه درس، ص 26 · نمای بیرونی آهیانه با کنارها، زوایا و خطوط گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: کنارها، زاویه‌ها، برجستگی آهیانه و خطوط گیجگاهی در سطح بیرونی استخوان با خطوط راهنما نشان داده شده‌اند.

- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- برجستگی آهیانه‌ای · Parietal tuberosity
- کنار پیشانی · Frontal margin
- کنار ساجیتال · Sagittal margin
- کنار پس‌سری · Occipital margin

ارجاع متن: جزوه درس، ص 26

استخوان دارای دو سطح External یا بیرونی یا بیرون جمجمه ای و سطح درونی است که در این تصویر شما سطح بیرونی را مشاهده می کنید. استخوان دارای چهار کنار می باشد که شامل:

منبع: متن جزوه درس، ص 26 — رونویسی در حال مقابله

- کنار قدامی (Frontal margin) که این کنار در قسمت فوقانی مقعر است و در تشکیل درز کرونال (Coronal suture) شرکت می کند و با استخوان Frontal مفصل می شود.
- کنار خلفی (Occipital margin) که با استخوان پس سری مفصل می شود و Lambdoid suture را تشکیل می دهد.
- کنار فوقانی (Sagittal margin) که Sagittal suture را تشکیل می دهد.
- کنار تحتانی (Squamous margin) که با صدف استخوان Tymporal مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 26 — رونویسی در حال مقابله

استخوان دارای چهار زاویه است:

منبع: متن جزوه درس، ص 26 — رونویسی در حال مقابله

- زاویه ای قدامی فوقانی (Frontal angle)
- زاویه قدامی تحتانی (Sphenoidal angle)
- زاویه ی خلفی فوقانی (Occipital angle)
- زاویه ی خلفی تحتانی (Mastoid angle)

منبع: متن جزوه درس، ص 26 — رونویسی در حال مقابله

بر روی سطح خارجی استخوان یک برجستگی به نام Parietal tuberosity وجود دارد یا برجستگی استخوان آهیانه که مراکز استخوان سازی در این قسمت وجود داشته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 26 — رونویسی در حال مقابله

در پایین برجستگی دو لاین یا دو خط دیده می شود که در بالا و پایین به اسم های خط گیجگاهی فوقانی (Superior temporal line) و خط گیجگاهی تحتانی (Inferior temporal line) که این دو خط از صدف استخوان Frontal شروع می شود و بر روی استخوان Parietal به سمت عقب و بالا رفته و در تشکیل حفره temporal شرکت و محدوده حفره temporal را مشخص می کنند.

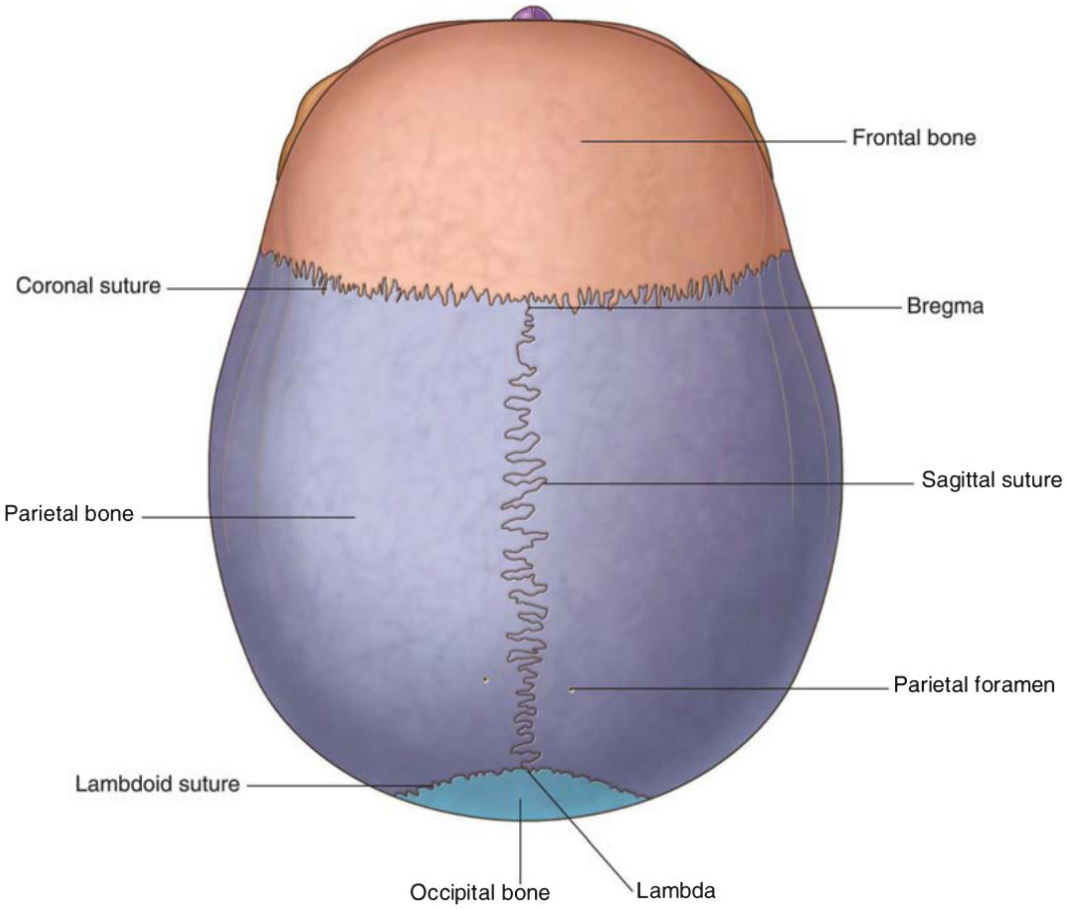
منبع: متن جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ — رونویسی در حال مقابله

خط تمپورال فوقانی (superior temporal line) در عقب کم کم محو میشود و محل اتصال فاسیای temporalis است اما خط تمپورال تحتانی (inferior temporal line) واضح تر و مشخص هست و محل اتصال عضله temporalis که از عضلات جونده است می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 27 — رونویسی در حال مقابله

کالواریا از نمای فوقانی در گری

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · شکل ۸.۲۱ گری



Superior view of the skull.

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای فوقانی خارجی، استخوان‌های پیشانی، آهیانه و پس‌سری، درزها، برگما، لامبدا و سوراخ آهیانه‌ای مشخص شده‌اند.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز تاجی · Coronal suture
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- برگما · Bregma

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۹: استخوان آهیانه — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ · گری، ص ۸۶۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا خط گیجگاهی تحتانی واضح‌تر از خط فوقانی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها

مبحث ۲۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۳۰ · پیش‌نیاز: سطح بیرونی آهیانه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از بیرون، آهیانه ساده است؛ از درون، جای سینوس ساجیتال و جوانه‌های عنکبوتیه است. پایان جلسه: درزها و فونتانل‌ها.

اهداف یادگیری

- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی و دو لبه آن را توصیف کنید.
- جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار را توضیح دهید.
- چهار فونتانل و زمان بسته شدنشان را بگویید.

کلیدواژه

Superior sagittal sinus · Granular foveolae · Arachnoid granulation · Fontanelle · Bregma · Lambda

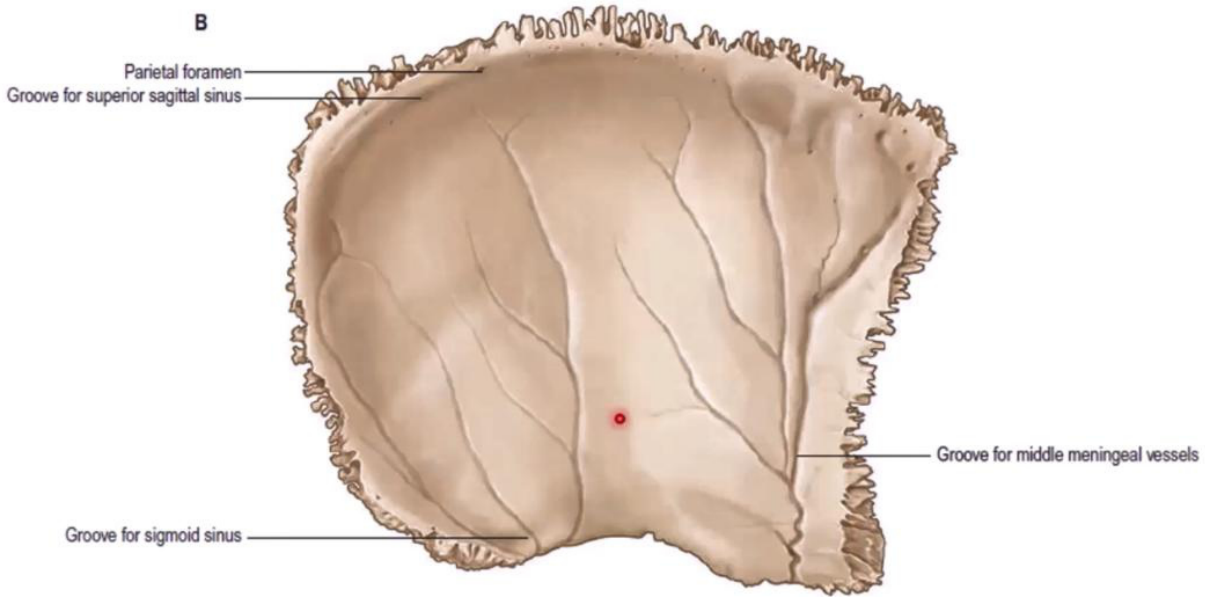
جزوه درس، ص ۲۷–۳۰ · گری، ص ۸۶۴ · نتر، پلیت ۳۵

نمای درون جمجمه استخوان parietal را مشاهده می کنید و باید توجه داشته باشید که کنار قدامی (سمت راست شکل): کنار قدامی آن به صورت مقعر است بنابراین از سمت درونی کنار خلفی می باشد. در سمت درونی استخوان (سمت چپ شکل) و parietal شکنج ها و تورفتگی هایی که مربوط به شکنج های نیمکره مخ است مشاهده می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 27 — رونویسی در حال مقابله

سطح داخلی استخوان آهیانه

جزوه درس، ص 27 · نمای درونی آهیانه؛ ناودان سینوس ساجیتال و شیارهای شریانی



توضیح تکمیلی تصویر: شیار سینوس ساجیتال فوقانی، شیار سینوس سیگموئید و شیار عروق منتژی میانی روی سطح داخلی نام‌گذاری شده‌اند.

- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی · Groove for superior sagittal sinus
- شیار عروق منتژی میانی · Groove for middle meningeal vessels
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- شیار سینوس سیگموئید · Groove for sigmoid sinus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 27

از زاویه قدامی تحتانی یا زاویه اسفنوییدال کانال یا شیاری عمیق به سمت بالا و عقب طی مسیر میکند که در این قسمت شاخه ای از شریان پرده مغزی میانی (middle meningeal vessels) قرار میگیرد که این شریان شاخه شاخه میشود و اثر آن بر روی استخوان به صورت شیار مشخص میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 27 — رونویسی در حال مقابله

نزدیک به کنار فوقانی نصف یک ناودان یا شیاریست که با طرف مقابل تشکیل سینوس ساجیتال فوقانی را میدهد که عمدتا در parietal وجود دارد البته کمی هم در استخوان فورنتال و آکسیپیتال موجود میباشد. به لبه های ناودان فالکس سربلی یا داس مغزی متصل می شود.

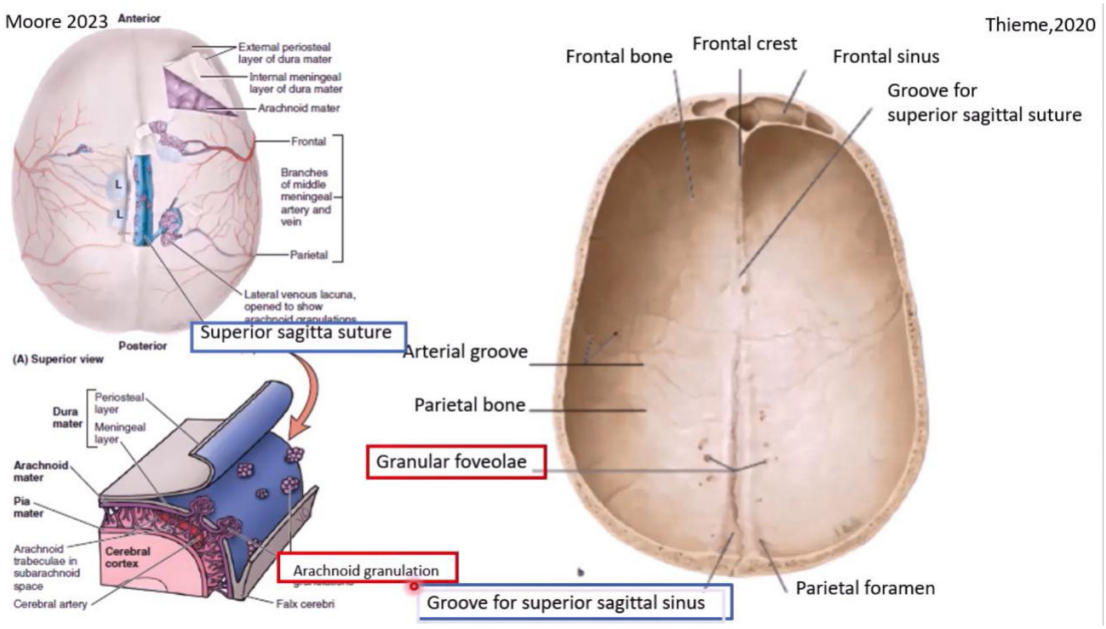
منبع: متن جزوه درس، ص 27 — رونویسی در حال مقابله

در تصویر پایین صفحه استخوان parietal با parietal طرف مقابل متصل شده و از نمای درون جمجمه شما به استخوان نگاه میکنید. ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی در وسط قابل مشاهده است و در دو طرف آن هم یک لبه ای وجود دارد که محل اتصال فالکس سربلی یا داس مغزی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 28 — رونویسی در حال مقابله

جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار

جزوه درس، ص 28 · نمای سینوس ساجیتال، جوانه عنکبوتیه و سطح داخلی کالواریا



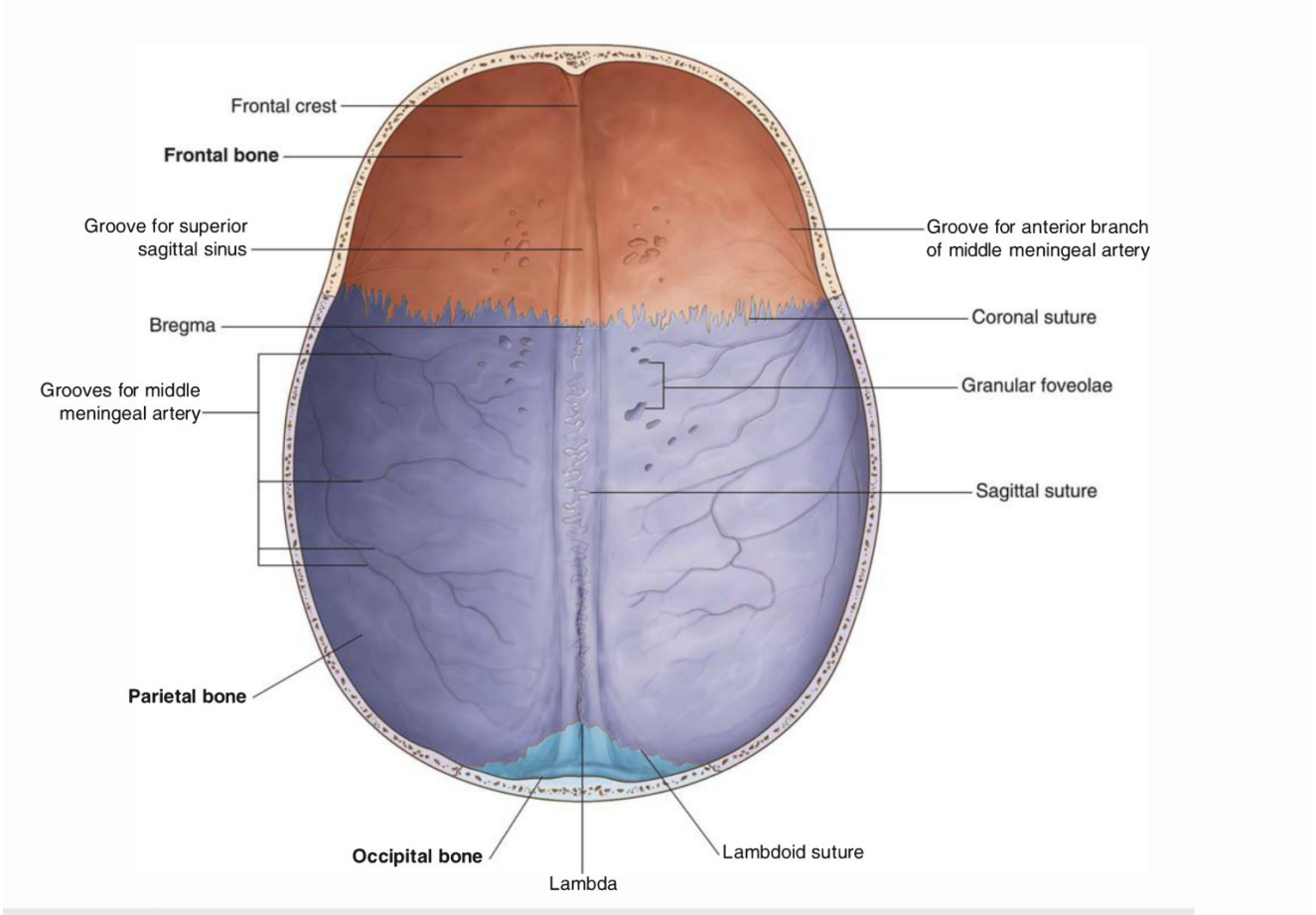
توضیح تکمیلی تصویر: ترکیب سه تصویر در منبع، موقعیت جوانه عنکبوتیه و اثر حفره‌های گرانولار در کنار شیار سینوس را نشان می‌دهد.

- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- جوانه عنکبوتیه · Arachnoid granulation
- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی · Groove for superior sagittal sinus
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 28 · نتر، پلیت ۳۸

سقف حفره کرانیال از درون

گری، شکل ۸.۲۴، ص ۸۶۴ · شکل ۸.۲۴ گری



Roof of the cranial cavity.

توضیح تکمیلی تصویر: سطح داخلی سقف جمجمه، شیار سینوس ساجیتال، حفره‌های گرانولار و شیارهای شریان مننژی میانی نام‌گذاری شده‌اند.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- شیار شریان مننژی میانی · Groove for middle meningeal artery
- برگما · Bregma
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۴، ص ۸۶۴

در دو طرف ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی حفراتی به نام granular foveolae وجود دارد که این اثرات مشابه اثراتی است که از پاشیدن خمیر بر روی ارزن به وجود می آید. این حفرات کوچک اثر جوانه های عنکبوتیه (Arachnoid granulation) که از این درون این جوانه های عنکبوتیه CSF به درون سینوس ساجیتال فوقانی تراوش می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 28 — رونویسی در حال مقابله

لازم به ذکر است سینوس ساجیتال فوقانی زمانی که قسمت سخت شامه دو لایه می شود فضایی به اسم سینوس وریدی را میسازد که قطر آن از ورید بزرگتر است و وریدهای به قسمت های سینوس ها تخلیه میشوند و از آنجا سینوس ها به درون ژوگولار اینترن تخلیه می شوند. هرچه از سینوس ساجیتال به سمت خارج برویم جوانه های عنکبوتیه روی استخوان بیشتر اثر میگذارند یعنی اینکه جوانه ها روی سینوس ساجیتال و سپس بر روی استخوان اثر میگذارند. پرزهای عنکبوتیه را Granulation هم می گویند و به آن ها همچنین جوانه های پاچینی گفته میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 28 — رونویسی در حال مقابله

کنار قدامی استخوان parietal با کنار خلفی استخوان پیشانی (frontal) درز کرونال (cronal suture) را تشکیل میدهد. کنار فوقانی استخوان parietal با استخوان طرف مقابل با هم درز میشود و درز ساجیتال (sagital suture) در خط وسط به وجود می آورد و کنار خلفی استخوان parietal هم با استخوان occipital مفصل شده و درز لامبدوییید (lambdoid suture) را به وجود می آورد.

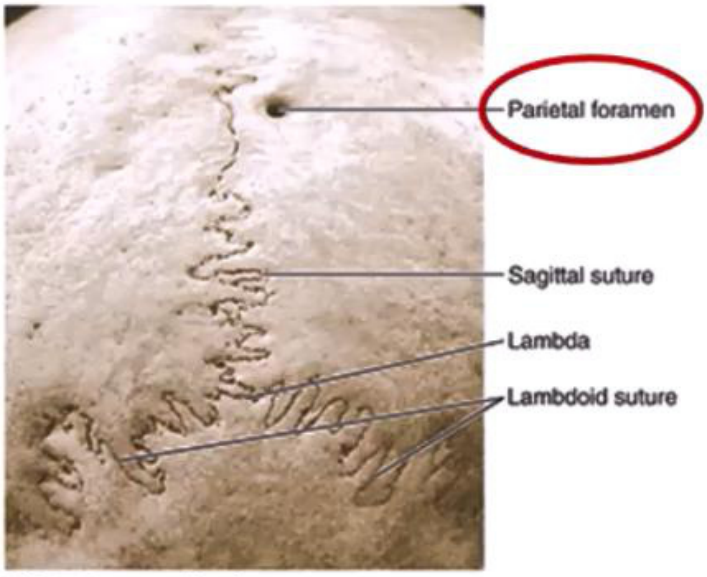
منبع: متن جزوه درس، ص 29 — رونویسی در حال مقابله

در قسمت خلفی استخوان نزدیک به کنار فوقانی یا ساجیتال سوراخ parietal foramen وجود دارد که وریدی از آن عبور که به آن پریتال ایمسری وین گفته میشود و همچنین شریان کوچکی نیز از شریان occipital از این قسمت عبور می کند. به محل اتصال درزهای ساجیتال و کرونال برگما و به محل اتصال درز های ساجیتال و لامبدوییید لاندا گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 29 — رونویسی در حال مقابله

سوراخ آهیانه‌ای در نمای خلفی-فوقانی

جزوه درس، ص 29 · Posterosuperior view؛ سوراخ آهیانه‌ای، درز ساجیتال، لاندا و درز لامبدوئیدی



(C) Posterosuperior view

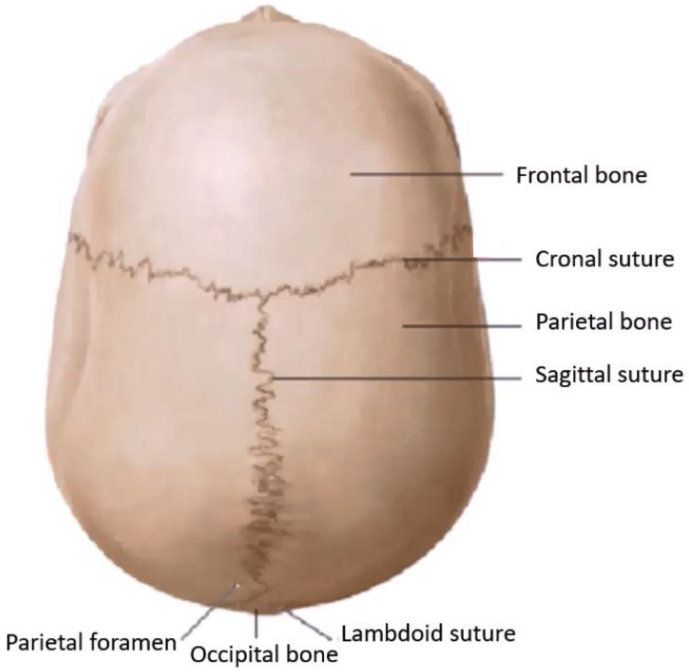
توضیح تکمیلی تصویر: سوراخ آهیانه‌ای در کنار درز ساجیتال و نزدیک لامبدا با دایره مشخص شده است.

- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- لاندا · Lambda
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 29

جمجمه و درزها از نمای فوقانی

Superior view of skull: sutures and parietal foramen · جزوه درس، ص 29



توضیح تکمیلی تصویر: این قاب درزهای جمجمه و سوراخ آهیانه‌ای را نشان می‌دهد؛ جای سوراخ کنار درز ساجیتال و نزدیک لاندا است.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز تاجی · Coronal suture
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

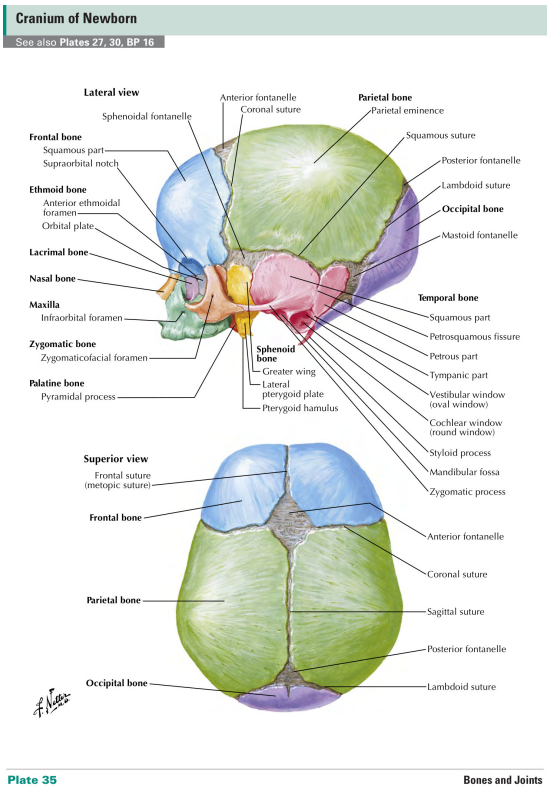
ارجاع متن: جزوه درس، ص 29

در دوران نوزادی (superior view): محل اتصال استخوان frontal و parietal تشکیل ملاج قدامی (Anterior fontanelle) را می دهد که در 18 ماهگی بسته میشود و اجازه رشد مغز را تا 2 سالگی به کودک میدهد. همچنین از محل اتصال استخوان Occipital و parietal فانتانل خلفی (posterior fontanelle) تشکیل میشود که در دو الی سه ماهگی بسته میشود. علت نامگذاری ملاج به این دلیل است که در زیر ملاج سینوس ساجیتال فوقانی قرار گرفته و در این قسمت جریان خون را احساس می کنیم مثل چشمه.

منبع: متن جزوه درس، ص 30 – رونویسی در حال مقابله

جمجمه نوزاد در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۵، ص ۸۷ · پلیت ۳۵ نتر



Cranium of Newborn

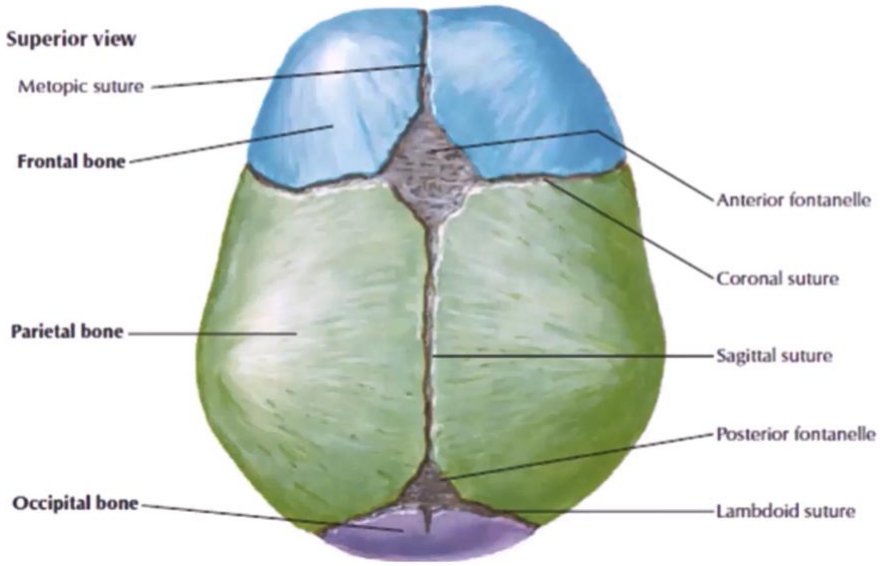
توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی ملاج‌های اسفنوئیدال و ماستوئیدی و در نمای فوقانی ملاج‌های قدامی و خلفی برچسب دارند.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- ملاج اسفنوئیدال · Sphenoidal fontanelle
- ملاج ماستوئید · Mastoid fontanelle
- درز تاجی · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 35

ملاج‌های قدامی و خلفی از نمای فوقانی

Skull of newborn: superior view — fontanelles and sutures · جزوه درس، ص 30



توضیح تکمیلی تصویر: در این نمای فوقانی، ملاج‌های قدامی و خلفی دیده می‌شوند؛ ملاج‌های طرفی در نمای بعدی مشخص‌اند.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- درز تاجی · Coronal suture
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

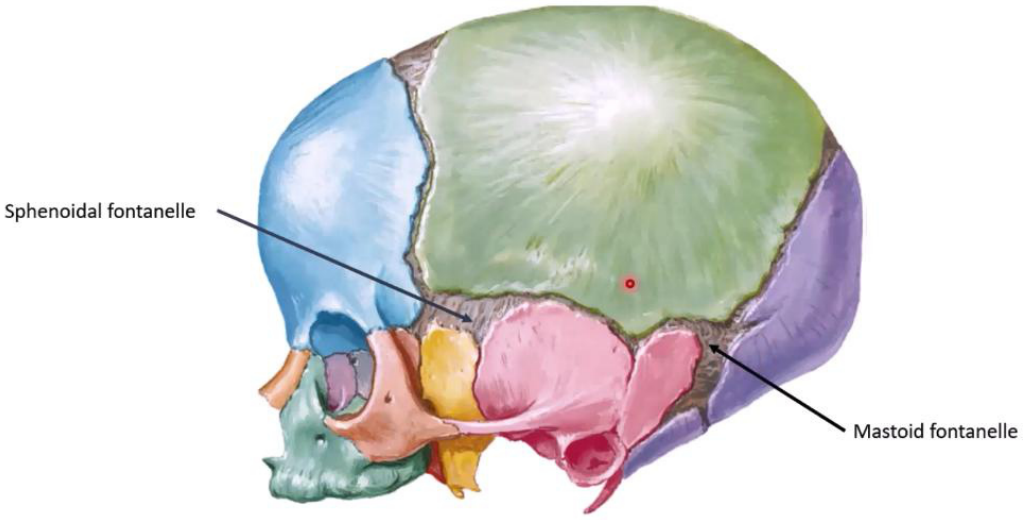
ارجاع متن: جزوه درس، ص 30

از کنار هم قرار گرفتن استخوان های parietal و frontal و استخوان sphenoid ملاج اسفنوییدال (sphenoidal fontanelle) شکل میگیرد و همچنین در کنار هم قرار گرفتن استخوان parietal و occipital و temporal فونتانل خلفی تحتانی (mastoid fontanelle) تشکیل میشود. بنابراین چهار فونتانل در نوزاد وجو دارد: قدامی و خلفی و اسفنوییدی و ماستوییدی.

منبع: متن جزوه درس، ص 30 — رونویسی در حال مقابله

ملاج اسفنوئیدال و ماستوئید از نمای طرفی

Skull of newborn: lateral view — sphenoidal and mastoid fontanelles · جزوه درس، ص 30



توضیح تکمیلی تصویر: در این نمای طرفی، محل ملاج‌های اسفنوئیدال و ماستوئیدی نشان داده شده است.

- ملاج اسفنوئیدال · Sphenoidal fontanelle
- ملاج ماستوئید · Mastoid fontanelle
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 30

امید است که این جزوه برای شما دوستان مفید واقع باشد با تشکر

منبع: متن جزوه درس، ص 30 — رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۲۰: آهیانه و ملاج‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۷–۳۰ · گری، ص ۸۶۴ · نتر، پلیت ۳۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: چرا نبض روی ملاج قدامی حس می‌شود و این با کدام ساختار زیر آن مربوط است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت

مبحث ۲۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۳۱–۳۳ · پیش‌نیاز: همه مبحث‌های این جلسه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جمع‌بندی پایان درس: سه نکته فشرده و ده کارت مرور. برای شب امتحان و برای کنترل اینکه چیزی جا نمانده باشد.

اهداف یادگیری

- با نگاه به هر کارت، محتوای مبحث مربوط را بازگو کنید.
- جدول سوراخ‌ها و شکستگی‌ها را از حافظه بنویسید.
- برای هر کارت، یک شکل این جلسه را نام ببرید.

کلیدواژه

Review · Zygomatic · Mandible · Fissures · TMJ · Fontanelles · Temporal lines

جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

۱ — Review. استخوان گونه (Zygomatic Bone)

استخوان زوج که برجستگی گونه را می‌سازد و در تشکیل دیواره خارجی و کف Orbit و حفرات Temporal و Infratemporal نقش دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

ساختار استخوان گونه

سطوح: Facial (خارجی)، Orbital (داخلی/چشمی)، Temporal (خلفی).

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **زوائد مهم**
  - Frontal Process: با استخوان فرونتال مفصل می‌شود ← درز Frontozygomatic
  - Temporal Process: با زائده زایگوماتیک تمپورال ← قوس گونه (Zygomatic Arch)

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **تکمات (Tubercles)**
  - Whitnall’s Tubercle: ۱ سانتی‌متر پایین‌تر از درز فرونتوزایگوماتیک
  - Marginal Tubercle: محل اتصال فاسیای عضله تمپورالیس

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **سوراخ‌ها (Foramina)**
  - Zygomaticofacial: عبور عصب و عروق همنام
  - Zygomaticotemporal: عبور عصب همنام
  - Zygomaticoorbital: ورود عصب زایگوماتیک (شاخه V_2)

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

نکته بالینی High Yield: ضربه به گونه ← شکستگی زائده فرونتال و جابجایی استخوان به داخل ← Double Vision (دوبینی) به دلیل جابجایی تکمه ویتنال و کشش Suspensory ligament. همچنین Black Eye در اثر پارگی شریان سوپرااوربیتال و تجمع خون در زیر پوست.

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **۲. استخوان فک تحتانی (Mandible)**

بزرگ‌ترین و قوی‌ترین استخوان صورت شامل یک تنه (Body-شکل U) و دو شاخ (Ramus).

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **نمای خارجی تنه**
  - Symphysis Menti: محل جوش خوردن دو نیمه مندیبل
  - Mental Protuberance: برجستگی چانه
  - Mental Foramen: سوراخ چانه‌ای (زیر دندان پرمولار ۲) ← خروج عصب و عروق Mental
  - Oblique Line: خط مایل از توبرکل منتال به سمت عقب و بالا

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **نمای داخلی تنه**
  - Mental Spines (Genial Tubercles): خارهای چانه‌ای (بالایی: Genioglossus، پایینی: Geniohyoid)
  - Mylohyoid Line: تقسیم تنه به دو حفره: Sublingual fossa (بالای خط ← غده زیرزبانی)، Submandibular fossa (پایین خط ← غده زیر فکی)
  - Mental Torus: برجستگی استخوانی زیر دندان‌های پرمولار (مزاحم برای دندان مصنوعی)

منبع: متن جزوه درس، ص 31 — رونویسی در حال مقابله

- **شاخ (Ramus)**

دو زائده در کنار فوقانی که توسط Mandibular Notch جدا می‌شوند:

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- Coronoid Process (قدامی): اتصال تاندون Temporalis
- Condylar Process (خلفی): شامل Head و گردن ← مفصل TMJ با حفره مندیبولار تمپورال
- Pterygoid Fovea: گودی در قدام گردن کندیل ← اتصال Pterygoid خارجی

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **سطح داخلی راموس**
- Mandibular Foramen: ورود عصب و عروق Inferior Alveolar
- Lingula: تیغه استخوانی در لبه سوراخ ← اتصال Pterygomandibular raphe
- Mylohyoid Groove: شیار از زیر لینگولا ← عبور عصب Mylohyoid
- Temporal Crest: برجستگی از کرونوئید به سمت مولار ۳
- Retromolar Fossa (Trigon): فضای پشت دندان عقل ← لندمارک بلاک عصبی و پروتز

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **۳. نکات تکاملی و تغییرات سنی**
- استخوان‌سازی: دو مرکز اصلی (هفته ۶ در محل سوراخ منتال و هفته ۱۰ در محل دندان‌های پیشین)
- جوش خوردن: دو نیمه مندیبل تا سال ۱ یا ۲ بعد از تولد در سمفیز کاملا جوش می‌خورند
- رشد طولانی: افزایش طول با اضافه شدن استخوان به کنار خلفی راموس و بازجذب از کنار قدامی
- دوران پیری: با افتادن دندان‌ها، زائده آلوئولار تحلیل ← سوراخ منتال و کانال مندیبولار به کنار فوقانی تنه نزدیک‌تر ← چانه جلوآمده (Prognatism)

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **۴. لندمارک‌های عصبی-عروقی در نمای قدامی**

فاصله از خط وسط (Midline) برای جراحی و بی‌حسی حیاتی است:

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- Supraorbital Foramen: ≈ ۳ سانتی‌متر از خط وسط
- Infraorbital Foramen: ≈ ۲.۵ سانتی‌متر از خط وسط (در راستای دندان پرمولار ۲ فک بالا)
- Mental Foramen: ≈ ۲.۵ سانتی‌متر از خط وسط (بین اپکس ریشه دندان‌های ۴ و ۵ فک پایین)

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **مفصل فکی-گیجگاهی (TMJ) و دررفتگی**
- Articular Tubercle: برجستگی مفصلی جلوی حفره فک تحتانی
- موقع باز کردن دهان، کندیل فک روی این برجستگی حرکت می‌کند
- Postglenoid Tubercle: جلوگیری از عقب‌رفتن بیش از حد فک

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **شکاف‌های حیاتی (Fissures)**

Petrotympanic Fissure: شکاف خاره‌ای-صماخی؛ محل عبور عصب Chorda Tympani (زوج ۷) + شریان صماخی قدامی.

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **مثلث فوق مجرایی (Suprameatal Triangle)**

اضلاع: ستیغ سوپراماستوئید (بالا)، مجرای گوش (پایین)، خط عمودی (عقب). اهمیت جراحی: در عمق ۱.۲۵ سانتی‌متری Antrum Mastoid قرار دارد ← دسترسی به عفونت‌های گوش میانی.

منبع: متن جزوه درس، ص 32 — رونویسی در حال مقابله

- **سوراخ استایلوماستوئید (Stylomastoid Foramen)**
  - بین زائده استایلوئید و ماستوئید
  - محل خروج عصب فاسیال (زوج ۷) از جمجمه
  - نکته تستی: آسیب ← فلج بل (Bell’s Palsy)

منبع: متن جزوه درس، ص 33 — رونویسی در حال مقابله

- **شیار شریان مننژیال میانی**
  - از زاویه قدامی-تحتانی (اسفنوئیدال) شروع می‌شود
  - پاره شدن در ضربات شقیقه ← خونریزی اپیدورال
  - لوسید اینتروال واضح (بیداری بین دو حالت کما)

منبع: متن جزوه درس، ص 33 — رونویسی در حال مقابله

- **Granular Foveolae**
  - فرورفتگی‌های اطراف سینوس ساژیتال
  - جایگاه Arachnoid Granulations
  - وظیفه: تخلیه CSF به داخل سینوس وریدی

منبع: متن جزوه درس، ص 33 — رونویسی در حال مقابله

- **خطوط گیجگاهی (Temporal Lines)**
  - خط فوقانی: اتصال فاسیای تمپورالیس
  - خط تحتانی: اتصال عضله تمپورالیس (واضح‌تر)
  - تشخیص در رادیوگرافی

منبع: متن جزوه درس، ص 33 — رونویسی در حال مقابله

- **درزها (Sutures) و لندمارک‌ها**
  - جلو با فرونتال ← Coronal
  - عقب با اکسیپیتال ← Lambdoid
  - بالا با آهیانه مقابل ← Sagittal
  - Bregma (برخورد ساژیتال و کرونال)
  - Lambda (برخورد ساژیتال و لامبدوئید)

منبع: متن جزوه درس، ص 33 — رونویسی در حال مقابله

- **ملاج قدامی (Anterior Fontanelle)**
  - بین فرونتال و پاریتال
  - بزرگ‌ترین ملاج، شکل لوزی
  - بسته شدن: ۱۸ ماهگی
  - کاربرد: بررسی فشار داخل جمجمه، لمس نبض

منبع: متن جزوه درس، ص 33 – رونویسی در حال مقابله

- **ملاج خلفی (Posterior Fontanelle)**
- بین پاریتال و اکسیپیتال
- شکل مثلثی
- بسته شدن: ۲–۳ ماهگی
- تشخیص موقعیت سر در زایمان

منبع: متن جزوه درس، ص 33 – رونویسی در حال مقابله

دررفتگی حاد TMJ: اگر کندیل فک از روی Articular Tubercle رد شود و بیفتد جلوی آن ← بیمار نمی‌تواند دهانش را ببندد. جااندازی: فشار فک به سمت پایین (برای رد شدن از برجستگی) + سپس هل دادن به عقب. خونریزی اپیدورال: پارگی Middle Meningeal Artery در ضربات شقیقه ← اورژانس جراحی!

منبع: متن جزوه درس، ص 33 – رونویسی در حال مقابله

یادداشت عضو تیم – چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل – مبحث ۲۱: مرور و جمع‌بندی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

پیش از انتشار، متن این مبحث را با صفحه‌های منبع مقابله کنید.

پرسش باز: کدام کارت مرور، مطلبی را می‌گوید که در متن اصلی جلسه نبود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما	این جلسه چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه و نمای طرفی را می‌آورد؟	☐
مبحث ۲ — استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده	گونه از استخوان‌های زوج صورت است و در کف و جدار خارجی کاسه چشم و دو حفره شریک است؟	☐
مبحث ۳ — زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای	درز پیشانی‌گونه‌ای یک لندمارک پوستی است و دو تکمه، دو اتصال متفاوت دارند؟	☐
مبحث ۴ — قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند	قوس گونه‌ای از دو استخوان ساخته می‌شود و مرز حفره گیجگاهی و زیرگیجگاهی است؟	☐
مبحث ۵ — سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن	سه سوراخ گونه‌ای هر کدام یک شاخه عصب گونه‌ای را عبور می‌دهند؟	☐
مبحث ۶ — آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی	شکستن زائده پیشانی‌گونه‌ای گونه را صاف می‌کند و با دوبینی می‌آید؟	☐
مبحث ۷ — مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز	مندیبل بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت است و از جسم و دو شاخ ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۸ — سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه	چهار کنار جسم و دو صفحه کورتیکال، مسیر شکستگی و بی‌حسی را تعیین می‌کنند؟	☐
مبحث ۹ — راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی	راموس دو زائده کورونوئید و کندیلار دارد و ناچ مندیبولار میان آن‌ها قرار می‌گیرد؟	☐
مبحث ۱۰ — شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع	هفت ناحیه به ترتیب احتمال شکستن، از جسم تا زائده کورونوئید؟	☐
مبحث ۱۱ — سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای	سطح داخلی جسم، محل اتصال دو عضله زبان و جای دو غده بزاقی است؟	☐
مبحث ۱۲ — سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رترومولار	چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل به کار می‌آیند؟	☐
مبحث ۱۳ — تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم	تغییرات سنی فک تحتانی و محل سوراخ منتال در تصویرهای جزوه؟	☐
مبحث ۱۴ — سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد	پنج سوراخ نمای قدامی و محتویات هر کدام در یک جدول؟	☐
مبحث ۱۵ — آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی	فاصله هر سوراخ از خط وسط و دامنه تغییرات آن روی پوست؟	☐
مبحث ۱۶ — نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی	استخوان گیجگاهی از چهار بخش صدفی، تیمپانیک، استایلوئید و پتروس ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۱۷ — برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی	مسیر حرکت کندیل روی برجستگی مفصلی و علت دررفتگی جلو؟	☐
مبحث ۱۸ — شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی	شکاف‌های صدفی‌تیمپانیک، تیغه تگمن، بخش تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید؟	☐
مبحث ۱۹ — استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی	چهار کنار، چهار زاویه و دو خط گیجگاهی که فاسیا و عضله گیجگاهی را نگه می‌دارند؟	☐
مبحث ۲۰ — سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها	ناودان سینوس ساجیتال، جوانه‌های عنکبوتیه، چهار فونتانل و سوراخ آهیانه‌ای؟	☐
مبحث ۲۱ — مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت	جمع‌بندی گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه در سه بند و ده کارت مرور؟	☐

جدول ۲-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۲
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۲ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: استخوان اسفنوئید و بال بزرگ و کوچک · استخوان پالاتین و صفحه عمودی آن · استخوان پس‌سری و بخش‌های قاعده‌ای · سوراخ‌ها و مجاری قاعده جمجمه.

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	پیش‌رو
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	همین جلسه
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	پیش‌رو
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	پیش‌رو
۵	ستون مهره‌های گردنی	پیش‌رو
۶	عضلات گردن: سطحی و هایوئیدی و عمقی	پیش‌رو
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۲-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۲ از ۱۳ — استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس